

METHODICAL
DIVISIÓN PROCESOS

Levantamiento de procesos

Gestión Comercial y Marketing Digital

Fecha
14 de agosto – 2026



3. Gestión Comercial, Marketing y Digital de MauleMed

3.1. Proceso de Negocio a Analizar

El proceso seleccionado para análisis corresponde a la **Gestión General y Marketing Digital de MauleMed**. Este proceso tiene como propósito planificar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones comunicacionales y comerciales desarrolladas principalmente mediante canales digitales, con el objetivo de fortalecer la visibilidad institucional, informar los servicios disponibles, generar consultas y agendamientos, fidelizar pacientes y apoyar el posicionamiento de la organización.

El proceso comienza cuando se identifica una necesidad de difusión o posicionamiento de un servicio, examen, campaña preventiva o contenido institucional. Estas necesidades pueden originarse desde Gerencia, Dirección Médica, Calidad o Administración, dependiendo de las prioridades institucionales, contingencias, campañas de prevención o prestaciones que requieran una mayor difusión.

A partir de la necesidad identificada, se desarrolla la planificación de la campaña, considerando aspectos como el servicio o tema a promocionar, el público objetivo, los objetivos esperados, el presupuesto disponible y los canales digitales que serán utilizados. Posteriormente, se gestiona la creación del contenido, ya sea de manera interna o con el apoyo de proveedores externos e influencers.

El contenido desarrollado es revisado antes de su publicación. Cuando incluye información clínica, también debe ser validado por los profesionales médicos correspondientes. Una vez aprobado, se publica mediante plataformas como Instagram, Facebook, Meta y, cuando corresponde, Google Ads.

Las interacciones generadas por las campañas son gestionadas principalmente mediante WhatsApp Business y otros canales digitales. El equipo de agendamiento responde las consultas de los pacientes y registra las horas concretadas en el sistema Cui.Date. Sin embargo, actualmente el sistema no permite identificar automáticamente si un paciente proviene de una campaña específica, lo que limita la trazabilidad entre las acciones de marketing, los agendamientos y las atenciones efectivamente realizadas.

Finalmente, los resultados disponibles son revisados con el objetivo de evaluar el alcance, las interacciones, los mensajes, el crecimiento de seguidores y el desempeño general de las campañas. A partir de esta información se definen acciones de mejora para futuras iniciativas comunicacionales y comerciales.

Durante el levantamiento también se identificaron dos procesos asociados al ámbito de Calidad y Experiencia Usaria: la **Gestión de Encuestas de Satisfacción** y la **Gestión de Reclamos**. Aunque estos procesos se encuentran relacionados con la experiencia de los pacientes y pueden generar información útil para la toma de decisiones institucionales, poseen gatillantes, responsables, actividades, reglas de negocio e indicadores propios. Por esta razón, fueron levantados y modelados mediante diagramas BPMN independientes.

A nivel general, el proceso principal de Gestión General y Marketing Digital puede descomponerse en las siguientes etapas:

1. Identificar una necesidad de difusión o posicionamiento.
2. Definir el servicio, examen o tema a promocionar.
3. Planificar la campaña digital.



4. Gestionar la aprobación de la campaña y su presupuesto.
5. Coordinar la creación del contenido.
6. Revisar y validar el contenido desarrollado.
7. Publicar o ejecutar la campaña digital.
8. Gestionar las consultas y agendamientos generados.
9. Revisar las métricas disponibles.
10. Analizar los resultados y definir acciones de mejora.

Debido a la importancia que tiene este proceso para la visibilidad institucional, la captación de pacientes y la comunicación de los servicios ofrecidos por MauleMed, resulta relevante comprender su funcionamiento actual, identificar sus principales brechas y generar una base de conocimiento que permita mejorar la trazabilidad y la toma de decisiones.

3.2. Motivación y Beneficios Esperados

3.2.1. Motivación

El proceso de Gestión General y Marketing Digital constituye un proceso relevante para MauleMed, ya que permite difundir los servicios ofrecidos por la organización, fortalecer su presencia institucional, generar consultas y agendamientos, fidelizar pacientes y apoyar campañas preventivas dirigidas a la comunidad.

Durante los últimos meses, MauleMed ha asumido una participación más directa en la planificación y ejecución de sus campañas digitales. Esta decisión se originó debido a que los servicios anteriormente gestionados por proveedores externos no entregaban suficiente información respecto de los resultados obtenidos y tampoco permitían observar avances claros en términos de agendamientos, alcance o crecimiento de la comunidad digital.

A partir de esta situación, Pilar Soto Aguilar y Liz comenzaron a participar directamente en la gestión de campañas, incorporando colaboraciones con influencers locales, contenido audiovisual e iniciativas orientadas a la prevención y difusión de determinados servicios. Estas acciones han permitido aumentar considerablemente el número de seguidores y generar un mayor movimiento de consultas y solicitudes de agendamento mediante el WhatsApp institucional.

Sin embargo, el proceso presenta limitaciones importantes relacionadas con la trazabilidad de los resultados. Aunque el equipo de agendamento responde los mensajes recibidos y registra las horas en Cui.Date, actualmente no existe un mecanismo automático que permita identificar si un paciente proviene de Instagram, Facebook, Google Ads, WhatsApp o una campaña específica.

Como consecuencia, la organización puede conocer indicadores digitales como alcance, interacciones, seguidores y mensajes, pero no puede determinar con exactitud cuántos agendamientos, pacientes atendidos o ingresos fueron generados por cada campaña. Esta situación dificulta la evaluación del impacto real de las acciones de marketing y limita la posibilidad de calcular indicadores como tasa de conversión, costo por agendamento o retorno de inversión.

Adicionalmente, gran parte de las métricas se revisa directamente dentro de las plataformas digitales, sin contar con un reporte consolidado o dashboard que permita relacionar los resultados comunicacionales con los resultados operacionales y comerciales de la institución.



Durante el levantamiento también se identificó que la Gestión de Encuestas de Satisfacción y la Gestión de Reclamos dependen en gran medida del trabajo realizado por el área de Calidad. Ambos procesos utilizan planillas, documentos, formularios y registros que requieren una alta intervención manual. Por ello, su documentación resulta relevante para identificar dependencias operativas, formalizar responsabilidades y establecer oportunidades de mejora futuras.

Por estos motivos, resulta pertinente realizar un levantamiento detallado de los tres flujos identificados, con énfasis en el proceso principal de Marketing Digital y en los procesos asociados de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos.

3.2.2. Beneficios Esperados

La realización del presente estudio permitirá obtener una comprensión integral del funcionamiento actual de la Gestión General y Marketing Digital de MauleMed, así como de los procesos asociados de Calidad y Experiencia Usuaria identificados durante el levantamiento.

Entre los beneficios esperados se encuentran:

- ◇ Documentar formalmente los procesos y actividades que actualmente se desarrollan en la organización.
- ◇ Identificar los principales actores, responsabilidades, decisiones y flujos de información involucrados.
- ◇ Mejorar la comprensión de la relación existente entre campañas digitales, consultas, agendamientos y pacientes atendidos.
- ◇ Evidenciar la falta de trazabilidad automática respecto del origen de los pacientes captados mediante campañas digitales.
- ◇ Identificar oportunidades para consolidar métricas digitales, operacionales y comerciales.
- ◇ Disminuir la dependencia de revisiones manuales y conocimientos individuales.
- ◇ Formalizar los flujos asociados a encuestas de satisfacción y gestión de reclamos.
- ◇ Identificar dependencias operativas concentradas en Administración y Calidad.
- ◇ Generar una base para la futura implementación de herramientas tecnológicas de automatización y reportería.
- ◇ Facilitar la toma de decisiones mediante información estructurada y disponible para Gerencia, Dirección y responsables de área.

3.3. Estado Actual del Proceso de Negocio

3.3.1. Descripción Narrativa del Proceso

Gestión General y Marketing Digital. El proceso de Gestión General y Marketing Digital de MauleMed tiene como finalidad coordinar acciones comunicacionales y comerciales orientadas a difundir servicios, fortalecer la presencia institucional, generar consultas y convertirlas en agendamientos.

El proceso se desarrolla principalmente a partir de una planificación mensual de campañas, aunque también pueden surgir iniciativas específicas debido a contingencias, campañas preventivas, necesidades institucionales o servicios que requieren mayor difusión.



La necesidad de desarrollar una campaña puede originarse desde Gerencia, Dirección Médica, Calidad o Administración. A partir de esta necesidad, Administración y Marketing definen el servicio, examen o tema que será promocionado, así como el público objetivo, los resultados esperados y el presupuesto disponible.

Posteriormente, se prepara una propuesta de campaña que debe ser presentada a Gerencia o Dirección para su revisión. Cuando la propuesta requiere modificaciones, Administración y Marketing ajustan su planificación y la presentan nuevamente. Una vez aprobada, se inicia la coordinación para desarrollar el contenido.

Dependiendo de las características de la campaña, el contenido puede ser elaborado internamente, mediante el proveedor audiovisual AyR o a través de una colaboración con influencers. En los casos en que se requiere apoyo externo, se buscan y contactan proveedores o colaboradores, se solicita una cotización o se evalúa la posibilidad de realizar un canje.

AyR participa principalmente en la grabación de videos, edición, diseño gráfico, apoyo creativo y generación de piezas comunicacionales. En el caso de los influencers, Pilar Soto Aguilar realiza la búsqueda, contacto y coordinación del contenido que será desarrollado.

Una vez recibido el material, Administración y Marketing revisan su contenido. Cuando este posee información clínica, debe ser revisado y validado por el equipo médico correspondiente antes de su publicación. Si el contenido presenta errores o requiere modificaciones, se solicitan ajustes al ejecutor responsable y se realiza una nueva revisión.

Una vez aprobado, el contenido se publica o la campaña digital es ejecutada mediante las plataformas definidas. Actualmente, MauleMed utiliza principalmente Instagram, Facebook y Meta, aunque también se han desarrollado campañas mediante Google Ads.

Después de publicada la campaña, los pacientes pueden visualizar el contenido e interactuar mediante redes sociales o WhatsApp Business. Los mensajes son respondidos principalmente por el equipo de agendamiento, quien entrega información y registra las horas concretadas en el sistema Cui.Date.

Actualmente, el sistema Cui.Date registra correctamente las horas agendadas, pero no incorpora información relacionada con el origen comercial del paciente. Esto impide conocer si el agendamiento fue generado a partir de una campaña específica, una publicación orgánica, una recomendación u otro canal de captación. En consecuencia, la organización pierde trazabilidad sobre el recorrido completo del paciente, dificultando la medición de indicadores como la tasa de conversión, el costo por adquisición de pacientes o el retorno de las campañas ejecutadas.

Finalmente, Administración y Marketing revisan las métricas disponibles proporcionadas por las distintas plataformas digitales, considerando principalmente indicadores de alcance, interacciones, seguidores, mensajes recibidos y rendimiento de las publicaciones. Sin embargo, este análisis se realiza de manera descentralizada, ya que la información se encuentra distribuida entre Meta Business Suite, Google Ads, WhatsApp Business y el sistema Cui.Date, sin una integración que permita relacionar automáticamente las campañas ejecutadas con los agendamientos obtenidos, las atenciones realizadas o los ingresos generados.

Como consecuencia, la evaluación del desempeño de las campañas depende de la revisión manual de múltiples fuentes de información y del conocimiento de los responsables del proceso. Si bien esta información permite orientar decisiones respecto de futuras campañas, actualmente no existe un



mecanismo que consolide los datos en un único repositorio ni que entregue una visión completa del impacto comercial generado por las acciones de marketing.

Si bien el proceso permite ejecutar campañas digitales de manera continua y mantener una presencia activa en los distintos canales de comunicación, gran parte de su gestión se sustenta en la experiencia de las personas responsables y en la utilización de herramientas que operan de manera independiente. Esta situación incrementa el esfuerzo requerido para analizar los resultados, limita la capacidad de realizar seguimiento integral al desempeño del proceso y dificulta la implementación de mecanismos sistemáticos de mejora continua.

Gestión de Encuestas de Satisfacción. La Gestión de Encuestas de Satisfacción corresponde a un proceso asociado al área de Calidad y Experiencia Usuaria. Su propósito es evaluar la percepción de los pacientes respecto de la atención recibida y detectar oportunidades de mejora en los distintos servicios prestados por la organización.

El proceso comienza con la planificación de las fechas de aplicación. Para ello, se utiliza un randomizador que permite seleccionar anticipadamente los días en que se aplicarán las encuestas durante el año. Este mecanismo busca evitar que la elección de los días dependa directamente de los ejecutores y reducir posibles sesgos en la selección.

Cuando llega la fecha seleccionada, el área de Calidad informa a las áreas involucradas que se realizará la aplicación de encuestas. Posteriormente, el personal designado selecciona a los pacientes que serán consultados, buscando cubrir los distintos servicios prestados por la institución.

La muestra utilizada considera normalmente doce pacientes. En términos generales, se busca aplicar al menos dos encuestas por servicio, dependiendo de la disponibilidad de pacientes y de las prestaciones realizadas durante la jornada.

La encuesta se aplica una vez finalizada la atención. El formulario institucional considera aspectos como el trato entregado por el personal de admisión, secretaría y apoyo; la atención de los profesionales clínicos; la claridad de la información entregada; la calidad general de la prestación; la comodidad de las salas de espera; la limpieza de las dependencias; la satisfacción general y la disposición del paciente a recomendar el centro.

Una vez recibidas las respuestas, los resultados son registrados y consolidados en planillas e informes de Calidad. Posteriormente, se revisan las observaciones entregadas por los pacientes.

Cuando no existen observaciones negativas o situaciones críticas, el resultado se incorpora directamente al registro de satisfacción. En cambio, cuando el paciente informa un problema, Calidad entrega retroalimentación al área involucrada y solicita una explicación o una propuesta de acción correctiva.

El área involucrada analiza la situación y entrega los antecedentes correspondientes. Calidad evalúa esta respuesta y determina si el caso puede gestionarse directamente con el área o si debe ser escalado a Dirección Médica debido a su gravedad o impacto.

Cuando se requiere escalamiento, Dirección Médica evalúa la situación y define los lineamientos o acciones correspondientes. Posteriormente, Calidad registra la acción correctiva o mejora acordada y actualiza los informes asociados.

De manera periódica, los resultados de las encuestas son consolidados para generar indicadores de satisfacción y evaluar el nivel de cumplimiento de su aplicación. Esta información es comunicada a



Dirección y a los responsables de las áreas involucradas con el objetivo de apoyar la implementación de acciones de mejora.

Es importante señalar que una observación negativa obtenida mediante una encuesta no constituye automáticamente un reclamo formal. Cuando la situación requiere una gestión formal, esta debe ser derivada al proceso de Gestión de Reclamos.

Gestión de Reclamos. La Gestión de Reclamos corresponde a un proceso asociado al área de Calidad y Experiencia Usaria, cuyo propósito es recibir, analizar y responder formalmente las situaciones planteadas por los pacientes dentro de los plazos establecidos por la organización.

Los reclamos pueden ser ingresados mediante formularios físicos, página web, correo electrónico, WhatsApp o atención presencial. Los reclamos recibidos mediante la página web son enviados al correo institucional destinado a Calidad y Administración.

Una vez recibido el reclamo, la persona encargada de Calidad revisa la información y se dirige presencialmente al área involucrada para comprender el problema, conocer el contexto inicial y obtener una primera explicación de lo ocurrido. Esta visita constituye una instancia preliminar de levantamiento y no reemplaza la retroalimentación formal que debe ser entregada posteriormente.

Después de comprender la situación, Calidad solicita los antecedentes mediante el canal oficial, principalmente correo electrónico. El área involucrada analiza el caso, prepara la información correspondiente y envía formalmente su retroalimentación.

Se considera un plazo aproximado de 48 horas para la entrega de antecedentes. Cuando la información no es recibida dentro del período esperado, Calidad reitera la solicitud hasta obtener los elementos necesarios para continuar con el análisis.

Con los antecedentes disponibles, Calidad verifica la información, registra formalmente el reclamo, asigna un folio correlativo y lo clasifica según su tipología. Entre las categorías utilizadas se encuentran información, trato al usuario, tiempos de espera, situaciones clínicas y aspectos logísticos.

Posteriormente, Calidad analiza los antecedentes y determina si el caso requiere la participación de Recursos Humanos. Esta participación se solicita cuando la situación requiere medidas correctivas, capacitación, retroalimentación al personal o seguimiento de compromisos relacionados con el paciente.

Luego, Calidad elabora una propuesta de respuesta formal que es enviada a Dirección Técnica para su revisión. Cuando la respuesta requiere modificaciones, esta es devuelta a Calidad para realizar los ajustes correspondientes. Una vez validada, se envía al paciente mediante correo electrónico o carta certificada, dependiendo de las características del caso.

La respuesta debe ser enviada dentro de un plazo máximo de quince días hábiles. Calidad controla el cumplimiento de este plazo y registra los incumplimientos para incorporarlos posteriormente a los indicadores del proceso.

Después de recibir la respuesta, el paciente dispone de cinco días hábiles para manifestar su disconformidad. Si el paciente no responde dentro de este período, el reclamo se considera cerrado. Si responde y manifiesta conformidad, el caso también se cierra. En cambio, si mantiene su disconformidad, se le informa la posibilidad de acudir a la Superintendencia correspondiente y se registra el cierre de la gestión interna.



Finalmente, el reclamo es archivado tanto física como digitalmente. El expediente contiene el formulario o comunicación inicial, el folio, los antecedentes recopilados, la retroalimentación de las áreas, la respuesta enviada y los registros de seguimiento correspondientes.

Los reclamos cerrados son incorporados a una base utilizada para el análisis trimestral. Este análisis constituye un ciclo periódico independiente del tratamiento individual de cada caso y considera la cantidad de reclamos, su tipología, las áreas involucradas, sus causas, el cumplimiento de los plazos y las acciones correctivas implementadas.

3.3.2. Elementos Principales que Describen el Proceso

Con el fin de comprender de mejor manera la Gestión General y Marketing Digital y los procesos asociados identificados durante el levantamiento, resulta necesario reconocer las principales entidades, etapas, ejecutores, clientes y proveedores que participan en su funcionamiento.

Entidades. Las principales entidades identificadas son las siguientes:

- ◇ **Necesidad de difusión o posicionamiento:** entidad de entrada que da origen a una campaña digital.
- ◇ **Propuesta de campaña:** entidad interna que contiene el servicio, público objetivo, objetivos, presupuesto y canales considerados.
- ◇ **Cotización o propuesta de colaboración:** entidad interna utilizada para evaluar el trabajo de proveedores externos o influencers.
- ◇ **Contenido audiovisual o gráfico:** entidad interna generada para la ejecución de campañas.
- ◇ **Validación clínica:** entidad interna utilizada cuando el contenido incluye información médica.
- ◇ **Campaña digital publicada:** entidad de salida correspondiente al contenido difundido mediante plataformas digitales.
- ◇ **Mensajes y consultas:** entidades de entrada generadas por pacientes a partir de campañas o publicaciones.
- ◇ **Agendamiento:** entidad interna registrada en Cui.Date cuando un paciente concreta una hora.
- ◇ **Métricas digitales:** entidades internas obtenidas desde Meta, Instagram, Facebook y Google Ads.
- ◇ **Formulario de encuesta:** entidad de entrada utilizada para evaluar la satisfacción de los pacientes.
- ◇ **Resultados de satisfacción:** entidad interna consolidada en planillas e informes de Calidad.
- ◇ **Observación negativa:** entidad interna que puede originar retroalimentación o acciones correctivas.
- ◇ **Reclamo:** entidad de entrada generada por un paciente mediante alguno de los canales disponibles.
- ◇ **Folio correlativo:** entidad interna utilizada para identificar y mantener trazabilidad del reclamo.
- ◇ **Antecedentes del área involucrada:** entidad interna utilizada para analizar los hechos reclamados.
- ◇ **Respuesta formal:** entidad de salida enviada al paciente dentro del plazo correspondiente.
- ◇ **Expediente de reclamo:** entidad de salida archivada física y digitalmente.



- ◇ **Informe trimestral:** entidad de salida utilizada para analizar indicadores, causas y oportunidades de mejora.

Etapas. A nivel macro, los procesos levantados pueden dividirse en las siguientes etapas:

1. **Gestionar campañas digitales:** considera la identificación de necesidades, planificación, aprobación, creación de contenido, publicación, interacción con pacientes y evaluación de resultados.
2. **Gestionar encuestas de satisfacción:** contempla la planificación de fechas, selección de pacientes, aplicación de encuestas, registro de resultados y tratamiento de observaciones.
3. **Gestionar acciones de mejora por satisfacción:** considera la retroalimentación a las áreas, escalamiento a Dirección Médica y consolidación periódica de indicadores.
4. **Gestionar reclamos individuales:** contempla la recepción, levantamiento inicial, solicitud de antecedentes, análisis, elaboración de respuesta, cierre y archivo del reclamo.
5. **Analizar reclamos trimestralmente:** considera la consolidación de los reclamos del período, evaluación de tendencias y definición de acciones de mejora institucional.

Ejecutores. Los principales ejecutores son los siguientes:

- ◇ **Administración / Marketing:** participa en la planificación, coordinación, publicación y evaluación de campañas.
- ◇ **Pilar Soto Aguilar:** participa en la coordinación de campañas, contacto con influencers, gestión de encuestas y actividades asociadas a Calidad.
- ◇ **Liz:** participa en la coordinación y ejecución de campañas digitales.
- ◇ **Gerencia / Dirección:** revisa y aprueba campañas relevantes y decisiones institucionales.
- ◇ **Equipo médico:** valida contenidos que incluyen información clínica.
- ◇ **Influencers:** colaboradores externos que apoyan campañas de difusión y posicionamiento.
- ◇ **Equipo de agendamiento:** responde consultas y registra horas en Cui.Date.
- ◇ **Personal designado:** aplica encuestas de satisfacción a los pacientes.
- ◇ **Calidad:** registra resultados, retroalimenta áreas, gestiona reclamos, controla plazos y elabora informes.
- ◇ **Áreas involucradas:** entregan antecedentes, explicaciones y acciones correctivas.
- ◇ **Dirección Médica / Dirección Técnica:** evalúa situaciones escaladas y valida respuestas formales.
- ◇ **Recursos Humanos:** participa cuando se requieren medidas correctivas, capacitación o seguimiento del personal.

Clientes. Los clientes de los procesos corresponden a:

- ◇ Pacientes actuales y potenciales de MauleMed.
- ◇ Gerencia y Dirección.
- ◇ Dirección Médica y Dirección Técnica.
- ◇ Administración y Marketing.
- ◇ Equipo de agendamiento.
- ◇ Áreas clínicas y administrativas.



- ◇ Comité de Calidad.

Proveedores. Los principales proveedores corresponden a:

- ◇ Gerencia, Dirección Médica, Calidad y Administración, como generadores de necesidades de difusión.
- ◇ Influencers y colaboradores externos.
- ◇ Plataformas digitales como Meta, Instagram, Facebook y Google Ads.
- ◇ Pacientes, como proveedores de consultas, respuestas de encuestas y reclamos.
- ◇ Áreas clínicas y administrativas, como proveedoras de antecedentes y retroalimentación.
- ◇ Cui.Date, como sistema de registro de horas agendadas.

3.3.3. Aplicación de Herramienta SIPOC

La herramienta SIPOC (*Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers*) permite representar de manera resumida los principales elementos que intervienen en un proceso de negocio. Su utilización facilita la identificación de los proveedores, entradas, actividades principales, salidas y clientes involucrados, proporcionando una visión general del funcionamiento del proceso.

Para el presente levantamiento, se decidió aplicar la herramienta SIPOC de manera diferenciada a los tres procesos identificados: Gestión General y Marketing Digital, Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos. Esta separación permite representar con mayor claridad sus respectivos proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, considerando que cada flujo posee objetivos, responsables y mecanismos de ejecución propios.

SIPOC del proceso de Gestión General y Marketing Digital. La Tabla 1 presenta el análisis SIPOC del proceso principal de Gestión General y Marketing Digital.



Tabla 1: Análisis SIPOC del proceso de Gestión General y Marketing Digital

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
Gerencia, Dirección Médica, Calidad y Administración	Necesidad de difusión o posicionamiento	1. Identificar necesidad de campaña	Necesidad comunicacional definida	Administración / Marketing
Administración / Marketing	Servicio, examen o tema a promocionar	2. Planificar campaña digital	Propuesta de campaña	Gerencia / Dirección
Gerencia / Dirección	Aprobación y presupuesto	3. Aprobar campaña y presupuesto	Campaña aprobada	Administración / Marketing
AyR, influencers y equipo médico	Contenido audiovisual, gráfico y validación clínica	4. Crear y validar contenido	Contenido aprobado	Pacientes actuales y potenciales
Meta, Instagram, Facebook y Google Ads	Plataformas digitales y herramientas de publicación	5. Publicar campaña digital	Campaña publicada	Comunidad digital
Pacientes y usuarios digitales	Mensajes, consultas y solicitudes de hora	6. Gestionar consultas y agendamientos	Consultas respondidas y horas registradas	Pacientes / MauleMed
Plataformas digitales, WhatsApp Business y Cui.Date	Métricas, mensajes y registros de agendamiento	7. Analizar resultados y definir mejoras	Indicadores disponibles y acciones de mejora	Gerencia, Dirección y Administración

Como se observa en la Tabla 1, el proceso comienza con una necesidad de difusión o posicionamiento y culmina con la evaluación de los resultados disponibles. La principal brecha identificada corresponde a la falta de trazabilidad entre las campañas digitales, los mensajes recibidos, los agendamientos, las atenciones efectivamente realizadas y los ingresos generados.

SIPOC del proceso de Gestión de Encuestas de Satisfacción. La Tabla 2 presenta el análisis SIPOC correspondiente al proceso asociado de Gestión de Encuestas de Satisfacción.



Tabla 2: Análisis SIPOC del proceso de Gestión de Encuestas de Satisfacción

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
Área de Calidad	Calendario anual y fechas seleccionadas mediante randomizador	1. Planificar aplicación de encuestas	Fechas de aplicación definidas	Personal designado
Pacientes	Experiencia de atención y percepción del servicio	2. Aplicar encuesta de satisfacción	Encuestas respondidas	Área de Calidad
Personal designado	Formularios respondidos	3. Registrar y consolidar resultados	Resultados consolidados	Calidad
Pacientes y áreas involucradas	Observaciones, explicaciones y antecedentes	4. Gestionar observaciones negativas	Retroalimentación y acciones correctivas	Dirección Médica / Áreas involucradas
Calidad	Resultados consolidados e indicadores	5. Analizar resultados periódicos	Indicadores de satisfacción e informe de resultados	Dirección y responsables de área

La aplicación del SIPOC permite evidenciar que el proceso depende de una adecuada selección de pacientes, del registro de resultados y de la capacidad de Calidad para coordinar la retroalimentación con las áreas involucradas. Asimismo, destaca la importancia de diferenciar entre una observación negativa obtenida mediante una encuesta y un reclamo formal.

SIPOC del proceso de Gestión de Reclamos. La Tabla 3 presenta el análisis SIPOC correspondiente al proceso asociado de Gestión de Reclamos.



Tabla 3: Análisis SIPOC del proceso de Gestión de Reclamos

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
Paciente	Reclamo ingresado mediante canal disponible	1. Recepcionar y comprender reclamo	Caso identificado y contexto preliminar	Área de Calidad
Área involucrada	Antecedentes, explicación y retroalimentación formal	2. Solicitar y recopilar antecedentes	Antecedentes del caso	Calidad
Calidad	Reclamo, antecedentes y tipología	3. Analizar y clasificar reclamo	Propuesta de respuesta	Dirección Técnica
Dirección Técnica y RR.HH.	Validación, lineamientos y medidas correctivas	4. Validar respuesta y acciones asociadas	Respuesta formal aprobada	Paciente
Calidad	Respuesta validada, plazos y expediente	5. Enviar respuesta, cerrar y archivar reclamo	Respuesta enviada y expediente cerrado	Paciente / MauleMed
Registros históricos de reclamos	Reclamos cerrados, tipologías, áreas y plazos	6. Analizar reclamos trimestralmente	Informe, indicadores y acciones de mejora	Gerencia, Dirección y Comité de Calidad

Como puede observarse en la Tabla 3, el proceso presenta una alta dependencia del área de Calidad, la cual concentra la recepción, levantamiento inicial, solicitud de antecedentes, análisis, control de plazos, elaboración de la respuesta, cierre y archivo del caso.

El análisis SIPOC también permite distinguir entre el tratamiento individual de cada reclamo y el ciclo periódico de análisis trimestral. El primer flujo tiene como objetivo responder y cerrar cada caso, mientras que el segundo busca consolidar información y definir acciones de mejora institucional.

3.3.4. Procesos Relacionados

La Gestión General y Marketing Digital mantiene relación con distintos procesos internos de MauleMed, los cuales proporcionan información de entrada, participan en la ejecución de actividades o utilizan los resultados generados por las campañas digitales.

En primer lugar, se relaciona con el proceso de **Gestión de Agendamientos**. Las campañas digitales buscan generar consultas y convertirlas en horas agendadas. Los mensajes provenientes de redes sociales y WhatsApp Business son respondidos por el equipo de agendamiento, quien registra las horas concretadas en Cui.Date. Sin embargo, actualmente no existe una funcionalidad que permita identificar automáticamente si el paciente proviene de una campaña, publicación o canal digital específico.

En segundo lugar, se encuentra relacionado con el proceso de **Atención Clínica**. Las campañas comunican servicios, exámenes y prestaciones disponibles, mientras que el equipo médico participa



en la validación de aquellos contenidos que incluyen información clínica. Asimismo, la disponibilidad de horas y la calidad de la atención entregada influyen directamente en el resultado de las acciones de difusión.

En tercer lugar, se relaciona con la **Gestión Comercial y Administrativa**. Las campañas se originan a partir de necesidades institucionales, comerciales o preventivas y requieren decisiones relacionadas con objetivos, público objetivo, presupuesto y canales de difusión. Gerencia, Dirección y Administración participan en la definición y aprobación de estas iniciativas.

En cuarto lugar, se encuentra relacionado con la **Gestión de Encuestas de Satisfacción**. Este proceso permite conocer la percepción de los pacientes respecto de la atención, el trato, la infraestructura, la limpieza, los tiempos de espera y la calidad general del servicio. Sus resultados pueden proporcionar información relevante para orientar contenidos comunicacionales, detectar oportunidades de mejora y fortalecer la experiencia usuaria.

En quinto lugar, se relaciona con la **Gestión de Reclamos**. Los reclamos permiten identificar situaciones recurrentes, áreas con mayores dificultades y brechas relacionadas con la atención de pacientes. La información obtenida puede utilizarse para apoyar la toma de decisiones institucionales y prevenir la difusión de mensajes que no se encuentren alineados con la experiencia real del usuario.

Finalmente, la Gestión General y Marketing Digital mantiene relación con la **Toma de Decisiones Estratégicas**. Las métricas de alcance, interacciones, mensajes y agendamientos permiten evaluar el desempeño de las campañas y orientar decisiones respecto de los servicios que deben promocionarse, los canales utilizados y los recursos asignados.

La Figura 1 presenta las principales relaciones identificadas.

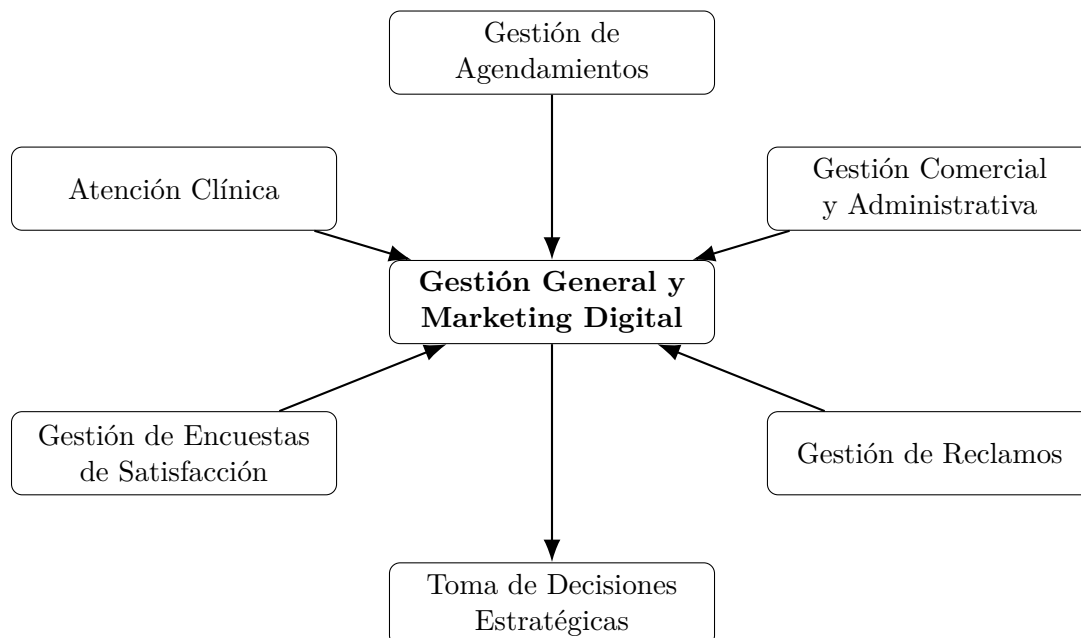


Figura 1: Procesos relacionados con la Gestión General y Marketing Digital de MauleMed

La relación entre estos procesos no implica que todos formen parte de un mismo flujo operacional. En particular, la Gestión de Encuestas de Satisfacción y la Gestión de Reclamos corresponden a



procesos asociados al ámbito de Calidad y Experiencia Usaria y fueron modelados de manera independiente debido a que poseen responsables, reglas de negocio e indicadores propios.

3.3.5. Herramientas de Apoyo

Para apoyar la ejecución de la Gestión General y Marketing Digital y de los procesos asociados identificados durante el levantamiento, MauleMed utiliza distintas herramientas tecnológicas, plataformas digitales, sistemas de información y documentos administrativos.

Herramientas utilizadas en Marketing Digital. En primer lugar, se utilizan **Instagram y Facebook** como los principales canales de comunicación digital de la organización. A través de estas plataformas se publican campañas, contenidos informativos, material audiovisual y piezas gráficas orientadas a difundir los servicios ofrecidos por MauleMed, fortalecer su presencia institucional y generar interacción con pacientes actuales y potenciales.

Para la administración de estas plataformas se emplea **Meta Business Suite**, herramienta que permite programar publicaciones y revisar indicadores como alcance, interacciones, seguidores, mensajes recibidos y rendimiento de las campañas. No obstante, la información obtenida permanece dentro de la plataforma y actualmente no se integra con otros sistemas utilizados por la organización.

Adicionalmente, MauleMed utiliza **Google Ads** para ejecutar campañas específicas de difusión. Sin embargo, la mayor parte de la actividad comunicacional se concentra en las plataformas administradas mediante Meta.

Por otra parte, **WhatsApp Business** constituye el principal canal de contacto con los pacientes una vez que estos interactúan con las campañas digitales. A través de este medio se responden consultas, se entrega información y se coordinan los agendamientos correspondientes.

El sistema **Cui.Date** es utilizado para registrar las horas agendadas. Sin embargo, no incorpora información sobre el canal de origen del paciente, lo que impide relacionar automáticamente los agendamientos con una campaña o publicación específica y limita la trazabilidad del proceso.

Asimismo, el **correo electrónico** se utiliza para coordinar actividades, revisar contenidos, mantener comunicación con proveedores externos y conservar respaldo de las decisiones adoptadas durante el desarrollo de las campañas.

Finalmente, la creación de contenido se apoya en distintas herramientas de edición y diseño utilizadas tanto por el equipo interno como por proveedores externos e influencers, las cuales permiten desarrollar material audiovisual y gráfico para las distintas iniciativas de difusión.

Herramientas utilizadas en Encuestas de Satisfacción. Para la planificación de las encuestas se utiliza un **randomizador**, mediante el cual se seleccionan anticipadamente los días en que se aplicarán las encuestas durante el año.

La aplicación se realiza mediante un **formulario institucional de satisfacción**, el cual contiene preguntas relacionadas con trato, atención clínica, calidad de la información, infraestructura, limpieza, satisfacción general y disposición a recomendar el centro.

Los resultados son registrados y consolidados mediante **planillas e informes de Calidad**. Estas herramientas permiten calcular porcentajes de satisfacción, revisar observaciones y generar indica-



dores periódicos.

La coordinación con las áreas involucradas se realiza principalmente mediante comunicación presencial, correo electrónico y otros mecanismos internos de coordinación.

Herramientas utilizadas en Gestión de Reclamos. Los reclamos pueden ser recibidos mediante **formularios físicos, página web, correo electrónico, WhatsApp** o atención presencial.

Los formularios físicos se encuentran disponibles en las áreas de admisión de las distintas instituciones. En el caso de los reclamos ingresados mediante la página web, estos son enviados al correo institucional destinado a Calidad y Administración.

El **correo electrónico** cumple un rol central en el proceso, ya que se utiliza para solicitar antecedentes a las áreas involucradas, recibir retroalimentación formal, enviar propuestas de respuesta a Dirección Técnica y mantener respaldo de las comunicaciones realizadas.

El seguimiento de los reclamos se realiza mediante un **archivo Excel**, registros en **Word** y carpetas institucionales. A cada reclamo se le asigna un folio correlativo y se controla su estado, fecha de ingreso, área involucrada, tipología, fecha de respuesta y cumplimiento del plazo.

Los expedientes son archivados tanto en **carpetas digitales** como en **archivadores físicos**. Estos registros contienen el reclamo original, el folio, los antecedentes recopilados, la retroalimentación del área, la respuesta enviada y los documentos asociados.

Finalmente, los resultados trimestrales son presentados mediante **informes, tablas, indicadores y gráficos**, los cuales permiten identificar tendencias, causas recurrentes, áreas con mayor número de reclamos y cumplimiento de los plazos establecidos.

Limitaciones identificadas. Aunque las herramientas disponibles permiten ejecutar los procesos, se observa una baja integración entre ellas. Las plataformas digitales, WhatsApp Business, Cui.Date, planillas, formularios y registros de Calidad operan de forma separada, lo que obliga a realizar consolidaciones manuales y limita la trazabilidad de la información.

En particular, no existe una herramienta integrada que permita relacionar automáticamente las campañas digitales con las consultas, agendamientos, pacientes atendidos e ingresos generados. De igual manera, las encuestas y reclamos dependen de registros manuales, documentos físicos y archivos que requieren una alta intervención del área de Calidad.

Estas limitaciones representan una oportunidad para avanzar hacia soluciones de automatización, reportería y visualización de indicadores que apoyen la gestión de los procesos y la toma de decisiones institucionales.

3.3.6. Aplicación de Herramienta RECI

La herramienta RECI permite identificar los distintos roles que participan en un proceso y el nivel de involucramiento que cada uno posee durante su ejecución. La sigla corresponde a Responsable (R), Ejecutor (E), Consultado (C) e Informado (I), permitiendo representar de manera estructurada la distribución de responsabilidades entre los distintos actores involucrados.

Su aplicación facilita la identificación de posibles concentraciones de funciones, dependencias entre áreas y oportunidades de mejora relacionadas con la asignación de responsabilidades. Asimismo,



constituye un complemento del modelado BPMN, ya que permite asociar cada actividad del proceso con los actores responsables de su ejecución y coordinación.

Para el presente levantamiento se elaboraron matrices RECI independientes para los procesos de Gestión General y Marketing Digital, Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos, considerando que cada uno posee objetivos, responsables y mecanismos de ejecución diferentes.

RECI del proceso de Gestión General y Marketing Digital. Para el proceso de Gestión General y Marketing Digital se identificaron los siguientes roles principales:

- ◇ **Administración / Marketing:** coordina la planificación, elaboración, publicación y evaluación de las campañas digitales.
- ◇ **Gerencia / Dirección:** revisa y aprueba campañas, presupuestos y decisiones estratégicas relacionadas con la difusión institucional.
- ◇ **Equipo médico:** valida los contenidos que incorporan información clínica antes de su publicación.
- ◇ **Proveedor externo:** participa, cuando corresponde, en la creación de contenido audiovisual, gráfico o publicitario para las campañas.
- ◇ **Influencer:** colabora en la generación y difusión de contenido según los objetivos definidos para cada campaña.
- ◇ **Equipo de agendamiento:** responde las consultas de los pacientes y registra las horas en Cui.Date.
- ◇ **Paciente / Usuario digital:** interactúa con las campañas, realiza consultas y eventualmente concreta un agendamiento.

La Tabla 4 presenta la matriz RECI correspondiente al proceso de Gestión General y Marketing Digital.



Tabla 4: Matriz RECI del proceso de Gestión General y Marketing Digital

Actividad	Adm. / Marketing	Gerencia / Dirección	Equipo médico	Proveedor externo	Influencer	Agendamiento	Paciente
Identificar necesidad de difusión o posicionamiento	E/R	C	C	I	I	I	-
Definir servicio, examen o tema a promocionar	E/R	C	C	I	I	I	-
Planificar campaña digital	E/R	C	C	I	I	I	-
Presentar propuesta de campaña	E/R	C	I	I	I	-	-
Revisar y aprobar propuesta de campaña	C	E/R	C	I	I	-	-
Definir y aprobar presupuesto	C	E/R	I	I	I	-	-
Seleccionar proveedor externo o influencer	E/R	I	I	C	C	-	-
Evaluar propuesta comercial o colaboración	E/R	C	I	C	C	-	-
Crear contenido digital	C	I	C	E/R	E	-	-
Preparar contenido internamente	E/R	I	C	-	-	-	-
Revisar contenido desarrollado	E/R	I	C	C	C	-	-
Validar información clínica	C	I	E/R	I	I	-	-
Aprobar contenido final	E/R	C	C	I	I	-	-
Publicar o ejecutar campaña digital	E/R	I	I	C	C	I	-
Visualizar e interactuar con la campaña	I	I	-	-	-	I	E
Responder consulta del paciente	I	I	-	-	-	E/R	C
Registrar hora en Cui.Date	I	I	-	-	-	E/R	C
Revisar métricas disponibles	E/R	I	I	I	I	C	-
Analizar resultados y definir mejoras	E/R	C	C	I	I	C	-

La matriz evidencia que Administración y Marketing concentra la mayor parte de las actividades relacionadas con la planificación, coordinación, revisión, publicación y evaluación de las campañas digitales. Por su parte, Gerencia y Dirección participan principalmente en la aprobación de campañas y presupuestos, mientras que el equipo médico interviene únicamente cuando el contenido requiere validación clínica.

Los proveedores externos e influencers participan de manera puntual en la creación de contenido, dependiendo de las características de cada campaña. Finalmente, el equipo de agendamiento cumple un rol relevante al responder las consultas de los pacientes y registrar las horas en Cui.Date. Sin embargo, el sistema utilizado actualmente no permite asociar automáticamente cada agendamiento con la campaña o canal de origen del paciente, limitando la trazabilidad del proceso y dificultando la evaluación del impacto real de las acciones de marketing.

RECI del proceso de Gestión de Encuestas de Satisfacción. Para el proceso de Gestión de Encuestas de Satisfacción se identificaron los siguientes roles:

- ♦ **Calidad:** planifica el proceso, registra los resultados, analiza las observaciones y coordina las acciones de mejora.
- ♦ **Personal designado:** selecciona pacientes y aplica las encuestas de satisfacción.
- ♦ **Paciente:** responde la encuesta y entrega su percepción respecto del servicio recibido.
- ♦ **Área involucrada:** analiza las observaciones y propone explicaciones o acciones correctivas.
- ♦ **Dirección Médica:** evalúa las situaciones que requieren escalamiento y define lineamientos o acciones.

La Tabla 5 presenta la matriz RECI correspondiente al proceso de Gestión de Encuestas de Satis-



facción.

Tabla 5: Matriz RECI del proceso de Gestión de Encuestas de Satisfacción

Actividad	Calidad	Personal designado	Paciente	Área involucrada	Dirección Médica
Seleccionar días mediante randomizador	E/R	I	-	I	I
Planificar aplicación de encuestas	E/R	C	-	I	I
Informar aplicación de encuestas	E/R	I	-	I	I
Seleccionar pacientes a encuestar	R	E	I	I	-
Verificar cobertura de servicios	R	E	-	C	-
Aplicar encuesta de satisfacción	R	E	C	-	-
Responder encuesta	I	C	E/R	-	-
Registrar resultados	E/R	C	-	-	-
Consolidar resultados	E/R	I	-	-	I
Revisar observaciones del paciente	E/R	C	-	C	I
Retroalimentar al área involucrada	E/R	I	-	C	I
Analizar observación y entregar respuesta	C	I	-	E/R	I
Evaluar respuesta del área	E/R	I	-	C	I
Determinar escalamiento a Dirección	E/R	I	-	C	C
Evaluar situación escalada	C	I	-	C	E/R
Definir lineamiento o acción	C	I	-	C	E/R
Registrar acción correctiva o mejora	E/R	I	-	C	I
Generar indicador de satisfacción	E/R	I	-	I	I
Comunicar resultados	E/R	I	-	I	C

La matriz muestra que el área de Calidad concentra la responsabilidad general del proceso, incluyendo su planificación, registro, análisis y seguimiento. El personal designado participa principalmente en la aplicación de las encuestas, mientras que las áreas involucradas deben analizar las observaciones y entregar respuestas cuando se identifican situaciones negativas.

Dirección Médica participa de manera excepcional cuando la gravedad o impacto de la situación requiere escalamiento. Por esta razón, su intervención no es permanente, sino condicionada a las características de cada caso.

RECI del proceso de Gestión de Reclamos. Para el proceso de Gestión de Reclamos se identificaron los siguientes roles:

- ◇ **Paciente:** ingresa el reclamo y recibe la respuesta formal.
- ◇ **Calidad:** concentra la coordinación, análisis, control de plazos, elaboración de respuesta, cierre y archivo del reclamo.
- ◇ **Área involucrada:** entrega una explicación inicial y posteriormente remite los antecedentes formales del caso.
- ◇ **Dirección Técnica:** revisa y valida la respuesta formal preparada por Calidad.
- ◇ **Recursos Humanos:** participa cuando se requieren medidas correctivas, capacitación o seguimiento del personal.



- ◇ **Gerencia / Dirección / Comité de Calidad:** revisan el análisis trimestral y participan en la definición de acciones de mejora institucional.

La Tabla 6 presenta la matriz RECI correspondiente al proceso de Gestión de Reclamos.

Tabla 6: Matriz RECI del proceso de Gestión de Reclamos

Actividad	Paciente	Calidad	Área involucrada	Dirección Técnica	RR.HH.	Gerencia / Comité
Ingresar reclamo	E/R	I	-	-	-	-
Recepcionar reclamo	C	E/R	I	I	I	-
Visitar presencialmente el área involucrada	I	E/R	C	I	I	-
Explicar preliminarmente la situación	-	C	E/R	I	I	-
Solicitar antecedentes por canal oficial	I	E/R	C	I	I	-
Analizar situación reclamada	-	C	E/R	I	I	-
Elaborar y enviar antecedentes del caso	-	C	E/R	I	I	-
Reiterar solicitud de antecedentes	-	E/R	C	I	I	-
Verificar antecedentes recibidos	-	E/R	C	I	I	-
Registrar reclamo	I	E/R	I	I	I	-
Asignar folio correlativo	I	E/R	I	I	I	-
Clasificar reclamo según tipología	I	E/R	C	I	I	-
Analizar antecedentes del reclamo	I	E/R	C	I	C	-
Determinar participación de RR.HH.	I	E/R	C	I	C	-
Apoyar definición de medidas correctivas	I	C	C	I	E/R	-
Elaborar propuesta de respuesta formal	I	E/R	C	C	C	-
Revisar propuesta de respuesta	I	C	I	E/R	I	-
Ajustar respuesta formal	I	E/R	C	C	I	-
Enviar respuesta formal al paciente	I	E/R	I	I	I	-
Recibir respuesta formal	E/R	I	-	-	-	-
Controlar plazo de 15 días hábiles	I	E/R	I	I	I	-
Registrar incumplimiento de plazo	I	E/R	I	I	I	I
Informar posibilidad de acudir a Superintendencia	I	E/R	-	I	I	-
Cerrar reclamo	I	E/R	I	I	I	-
Archivar reclamo físico y digital	I	E/R	I	I	I	-
Consolidar reclamos del periodo	-	E/R	I	I	I	I
Elaborar análisis trimestral	-	E/R	C	C	C	I
Revisar análisis trimestral	-	C	I	C	C	E/R
Definir acciones de mejora institucional	-	C	C	C	C	E/R

La matriz permite observar una alta concentración de responsabilidades en el área de Calidad. Esta unidad participa en prácticamente todas las etapas del proceso, desde la recepción inicial y levantamiento presencial del caso hasta la elaboración de la respuesta, control de plazos, cierre, archivo y análisis trimestral.

Las áreas involucradas cumplen un rol relevante en la explicación inicial del problema y en la entrega formal de antecedentes. Dirección Técnica participa en la validación de las respuestas, mientras que



Recursos Humanos interviene cuando se requieren medidas correctivas o acciones relacionadas con el personal.

Finalmente, Gerencia, Dirección y el Comité de Calidad participan principalmente en el ciclo periódico de análisis, utilizando la información consolidada para definir acciones de mejora institucional.

3.3.7. Modelado BPMN de los Procesos

BPMN (*Business Process Model and Notation*) es una notación estandarizada utilizada para representar gráficamente procesos de negocio mediante diagramas que describen actividades, eventos, decisiones, responsables y flujos de información. Su utilización facilita la comprensión del funcionamiento de un proceso, permite documentar su ejecución y constituye una herramienta de apoyo para el análisis y la identificación de oportunidades de mejora.

Con el objetivo de representar el estado actual de los procesos levantados en MauleMed, se desarrollaron modelos BPMN a partir de la información recopilada durante las entrevistas realizadas con los responsables de cada proceso y de la posterior validación efectuada por la organización.

Durante el levantamiento se identificó que la Gestión General y Marketing Digital agrupa tres procesos que, aunque mantienen relación entre sí, poseen objetivos, responsables y reglas de negocio diferentes. El primero corresponde a la gestión de campañas digitales y difusión institucional, mientras que los otros dos pertenecen al ámbito de Calidad y Experiencia Usaria: la Gestión de Encuestas de Satisfacción y la Gestión de Reclamos.

Por esta razón, cada uno fue modelado mediante un diagrama BPMN independiente, permitiendo representar con mayor claridad sus actividades, decisiones, responsables y puntos de interacción, evitando incorporar en un mismo flujo actividades que corresponden a procesos distintos.

Modelo BPMN de Gestión General y Marketing Digital La Figura 2 presenta el modelo BPMN correspondiente al proceso de Gestión General y Marketing Digital.

El proceso comienza cuando la organización identifica la necesidad de difundir un servicio, examen, campaña preventiva o contenido institucional. A partir de esta necesidad, el área de Administración y Marketing define el objetivo de la campaña, el público objetivo, el presupuesto disponible y la estrategia comunicacional que será desarrollada.

Posteriormente, la propuesta es revisada y, cuando corresponde, sometida a la aprobación de Gerencia o Dirección. En aquellos casos en que el contenido incorpora información clínica, este también debe ser validado por el equipo médico antes de su publicación.

Una vez aprobada la campaña, se determina si el contenido será elaborado internamente o con apoyo de proveedores externos o colaboradores. Posteriormente, el material desarrollado es revisado y, una vez aprobado, publicado a través de las plataformas digitales definidas.

Luego de la publicación, los pacientes pueden interactuar mediante redes sociales o WhatsApp Business, canal a través del cual el equipo de agendamiento responde consultas y registra las horas solicitadas en Cui.Date.

Finalmente, el proceso concluye con la revisión de las métricas disponibles y el análisis de los resultados obtenidos, información que sirve de apoyo para la planificación de futuras campañas.

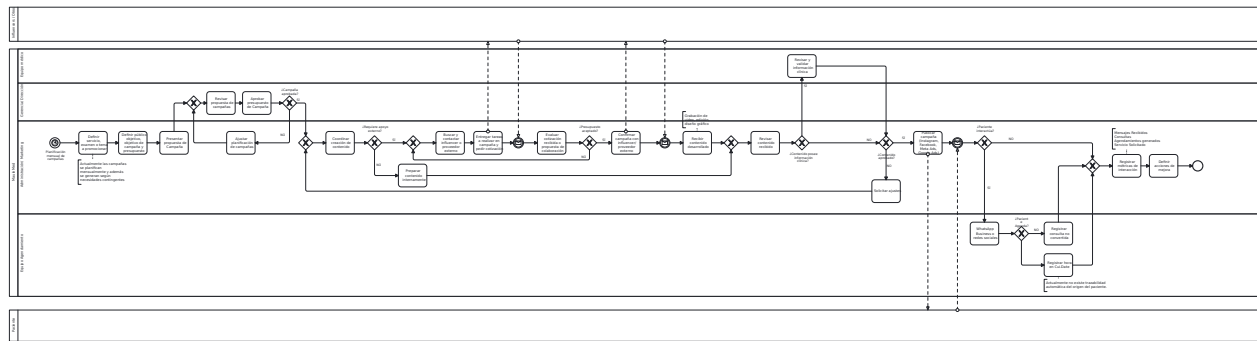


Figura 2: Modelo BPMN del proceso de Gestión General y Marketing Digital

El modelo evidencia que el proceso involucra la coordinación de distintas áreas de la organización y la participación de actores externos en determinadas campañas. Asimismo, permite visualizar una de las principales oportunidades de mejora identificadas durante el levantamiento: la inexistencia de una integración entre las plataformas digitales, WhatsApp Business y Cui.Date, lo que impide realizar un seguimiento completo desde la difusión de una campaña hasta la atención efectiva del paciente y dificulta evaluar el impacto comercial de las acciones de marketing.

Modelo BPMN de Gestión de Encuestas de Satisfacción La Figura 3 presenta el modelo BPMN correspondiente al proceso de Gestión de Encuestas de Satisfacción.

El proceso comienza con la planificación anual de las fechas de aplicación de las encuestas mediante un randomizador. Posteriormente, el personal designado selecciona a los pacientes que serán encuestados procurando representar los distintos servicios prestados por la institución.

Una vez finalizada la atención, se aplica la encuesta de satisfacción y se registran las respuestas obtenidas. Posteriormente, el área de Calidad consolida la información y revisa los resultados obtenidos.

Cuando se detectan observaciones negativas, estas son comunicadas al área involucrada para solicitar antecedentes y evaluar posibles acciones de mejora. Dependiendo de la gravedad de la situación, el caso puede escalar a Dirección Médica para definir los lineamientos correspondientes.

Finalmente, las acciones implementadas son registradas y los resultados consolidados pasan a formar parte de los indicadores utilizados para realizar seguimiento a la satisfacción de los pacientes.

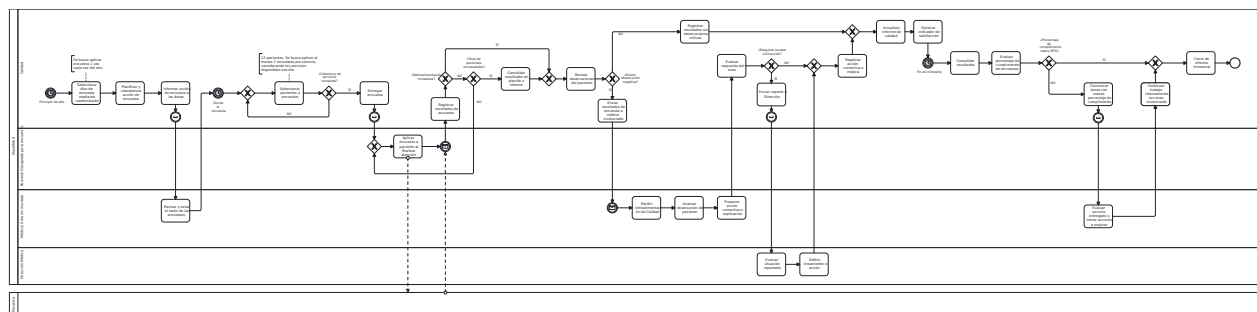


Figura 3: Modelo BPMN del proceso de Gestión de Encuestas de Satisfacción



El modelo permite apreciar que el área de Calidad concentra la coordinación del proceso, desde su planificación hasta el análisis de los resultados y el seguimiento de las acciones implementadas. Asimismo, evidencia que las observaciones obtenidas mediante las encuestas constituyen un mecanismo preventivo orientado a la mejora continua y no corresponden necesariamente a un reclamo formal.

Modelo BPMN de Gestión de Reclamos La Figura 4 presenta el modelo BPMN correspondiente al proceso de Gestión de Reclamos.

El proceso comienza cuando un paciente presenta un reclamo a través de alguno de los canales habilitados por la organización. Una vez recibido, el área de Calidad realiza un levantamiento inicial de la situación y recopila antecedentes con el área involucrada para comprender el contexto del caso.

Posteriormente, se solicitan formalmente los antecedentes correspondientes. Con la información recopilada, Calidad registra el reclamo, asigna un folio correlativo y clasifica el caso según su tipología.

A continuación, se analiza la situación y, cuando corresponde, se solicita apoyo a Recursos Humanos para evaluar acciones relacionadas con el personal involucrado. Posteriormente, se elabora una propuesta de respuesta formal, la cual es revisada por Dirección Técnica antes de ser enviada al paciente.

Finalmente, el reclamo es cerrado y archivado junto con toda la documentación asociada. De manera periódica, el área de Calidad consolida la información de los reclamos gestionados para elaborar informes que permitan identificar tendencias, áreas críticas y oportunidades de mejora para la organización.

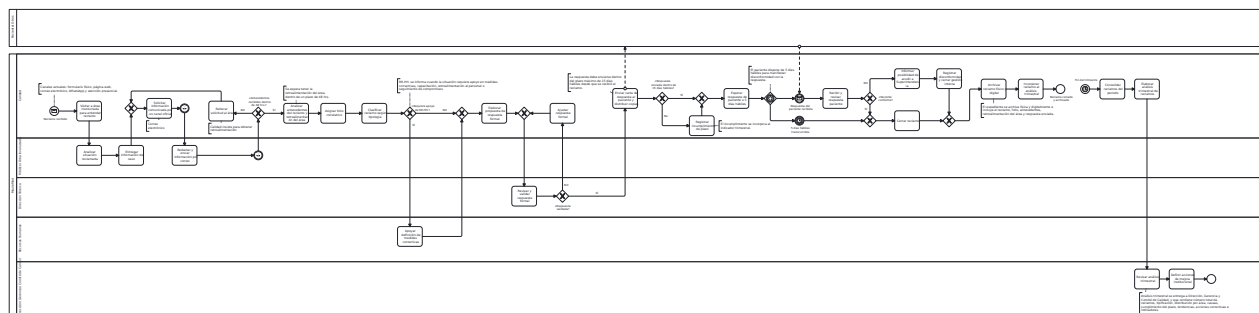


Figura 4: Modelo BPMN del proceso de Gestión de Reclamos

El modelo evidencia que el área de Calidad actúa como principal articulador del proceso, coordinando la recopilación de antecedentes, el análisis de cada caso, la elaboración de la respuesta formal y el control de los plazos establecidos. Asimismo, permite distinguir claramente entre el tratamiento individual de cada reclamo y el análisis periódico de la información consolidada, utilizado para apoyar la mejora continua de la organización.

3.4. Aplicación del Modelo de Madurez de Hammer

Con el propósito de complementar el levantamiento realizado, se aplicó el Modelo de Madurez de Procesos propuesto por Michael Hammer, el cual permite evaluar las capacidades organizacionales



que sustentan la ejecución de un proceso y determinar su nivel de desarrollo desde una perspectiva de gestión.

A diferencia de otros enfoques centrados únicamente en los resultados obtenidos, este modelo analiza las condiciones que permiten que un proceso sea ejecutado de manera consistente, controlada y sostenible en el tiempo. Para ello, considera cinco facilitadores fundamentales: Diseño, Ejecutores, Responsable, Infraestructura y Métricas.

La evaluación presentada en este estudio se desarrolló utilizando como evidencia la información recopilada durante las entrevistas realizadas en MauleMed, la documentación entregada por la organización, el análisis de las herramientas actualmente utilizadas y los modelos BPMN, matrices SIPOC y matrices RECI elaborados durante el levantamiento.

Considerando que la Gestión General y Marketing Digital mantiene una estrecha relación con los procesos de Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos, la evaluación se realizó de manera integrada. Esta decisión permite analizar las capacidades organizacionales compartidas por los tres procesos, especialmente en aspectos relacionados con la coordinación entre áreas, la utilización de herramientas tecnológicas, la gestión de la información y los mecanismos de seguimiento actualmente existentes.

3.5. Modelo de Madurez de Hammer

El Modelo de Madurez de Hammer evalúa cinco facilitadores que, en conjunto, determinan la capacidad de una organización para ejecutar un proceso de manera consistente, controlada y sostenible. Cada facilitador se descompone en un conjunto de capacidades específicas, denominadas *capabilities*, que permiten analizar distintos aspectos del proceso.

La Tabla 7 presenta los cinco facilitadores considerados por el modelo.



Tabla 7: Facilitadores del Modelo de Madurez de Hammer

Facilitador	Descripción
Diseño	Evalúa la forma en que el proceso ha sido concebido, considerando la definición de su propósito, su integración con el contexto organizacional y el grado de documentación existente.
Ejecutores	Evalúa si las personas que participan en el proceso poseen los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para ejecutarlo de manera efectiva.
Responsable	Analiza la existencia de un responsable del proceso, o <i>Process Owner</i> , con autoridad para coordinar su ejecución, monitorear su desempeño e impulsar iniciativas de mejora.
Infraestructura	Evalúa el soporte organizacional disponible para el proceso, incluyendo los sistemas de información y los mecanismos de gestión de recursos humanos.
Métricas	Evalúa la existencia y utilización de indicadores que permitan monitorear el desempeño del proceso y apoyar la toma de decisiones.

Cada facilitador se encuentra compuesto por distintas capacidades. La Tabla 8 presenta las *capabilities* utilizadas en la evaluación.



Tabla 8: Capabilities evaluadas en el Modelo de Hammer

Facilitador	Capability	Descripción
Diseño	Propósito	Evalúa si el objetivo del proceso se encuentra claramente definido y alineado con las necesidades de la organización.
	Contexto	Evalúa si el proceso se encuentra adecuadamente relacionado con sus clientes, proveedores y otros procesos de la organización.
	Documentación	Evalúa el grado en que el proceso, sus actividades y sus reglas de negocio se encuentran formalmente documentados.
Ejecutores	Conocimiento	Evalúa el nivel de comprensión que poseen los participantes respecto del propósito, funcionamiento y contexto del proceso.
	Habilidades	Evalúa si los ejecutores poseen las competencias necesarias para realizar correctamente las actividades asignadas.
	Comportamiento	Evalúa si las conductas y formas de colaboración de los participantes favorecen el cumplimiento de los objetivos del proceso.
Responsable	Identidad	Evalúa la existencia de un responsable claramente identificado para coordinar el proceso.
	Actividades	Evalúa el grado en que el responsable monitorea activamente el desempeño e impulsa iniciativas de mejora continua.
Infraestructura	Sistema de información	Evalúa el soporte tecnológico disponible para ejecutar, controlar y analizar el proceso.
	Recursos Humanos	Evalúa los mecanismos organizacionales que apoyan la formación, desarrollo y desempeño de los ejecutores.
Métricas	Definición	Evalúa si existen indicadores formalmente definidos para medir el desempeño del proceso.
	Uso	Evalúa si los indicadores son utilizados de manera sistemática para gestionar y mejorar el proceso.



3.6. Escala de Madurez

Cada *capability* puede alcanzar distintos niveles de desarrollo dentro del Modelo de Hammer. El modelo contempla una progresión desde capacidades inexistentes o incipientes hasta capacidades completamente institucionalizadas e integradas dentro de la organización.

En el presente estudio se utiliza la escala completa P0–P4. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia recopilada durante el levantamiento, ninguna de las capacidades evaluadas presenta características suficientes para alcanzar los niveles P3 o P4. Por esta razón, los resultados obtenidos se concentran principalmente entre los niveles P1 y P2.

La Tabla 9 presenta la interpretación utilizada para caracterizar cada nivel.

Tabla 9: Escala de madurez utilizada en la evaluación

Color	Nivel	Interpretación utilizada en este estudio
	P0	La <i>capability</i> no presenta evidencia suficiente de implementación o su desarrollo es inexistente o incipiente.
	P1	La <i>capability</i> se encuentra parcialmente desarrollada. Existen prácticas implementadas, aunque dependen significativamente de conocimiento tácito, herramientas aisladas o mecanismos informales.
	P2	La <i>capability</i> se encuentra implementada y es aplicada de forma consistente durante la ejecución del proceso, aunque todavía no presenta una integración transversal dentro de la organización.
	P3	La <i>capability</i> se encuentra integrada transversalmente dentro de la organización y es gestionada de manera sistemática.
	P4	La <i>capability</i> forma parte de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a la optimización permanente del proceso.

3.7. Evaluación de Madurez

La Tabla 10 presenta el resultado de la evaluación de las capacidades asociadas al proceso de Gestión General y Marketing Digital y a los procesos relacionados de Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos.

Para cada *capability* se indica el nivel de madurez alcanzado de acuerdo con la evidencia recopilada durante el levantamiento. La evaluación considera de manera conjunta los tres procesos, ya que comparten responsables, herramientas, mecanismos de coordinación y diversas limitaciones relacionadas con la integración de la información y la gestión basada en indicadores.



Tabla 10: Evaluación de madurez del proceso según el Modelo de Hammer

Facilitador	Capability	P0	P1	P2	P3	P4
Diseño	Propósito			✓		
	Contexto			✓		
	Documentación		✓			
Ejecutores	Conocimiento			✓		
	Habilidades			✓		
	Comportamiento		✓			
Responsable	Identidad			✓		
	Actividades		✓			
Infraestructura	Sistema de información		✓			
	Recursos Humanos		✓			
Métricas	Definición		✓			
	Uso		✓			

3.8. Justificación de la Evaluación

Con el objetivo de respaldar la evaluación presentada en la Tabla 10, a continuación se expone la evidencia recopilada durante el levantamiento que sustenta el nivel asignado a cada *capability*. La justificación se basa en las entrevistas realizadas, la información complementaria proporcionada por la organización, el análisis documental, las matrices RECI y los modelos BPMN desarrollados para representar el funcionamiento actual de los procesos.

La evaluación considera conjuntamente el proceso principal de Gestión General y Marketing Digital y los procesos asociados de Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos. Esta decisión se fundamenta en que los tres procesos comparten responsables, herramientas, mecanismos de coordinación y brechas relacionadas con la formalización, integración y utilización de la información.



Tabla 11: Justificación de la evaluación de las capabilities del Modelo de Hammer

Capability	Nivel	Justificación
Propósito	P2	Los tres procesos poseen un propósito claramente definido y comprendido por sus responsables. La Gestión General y Marketing Digital busca fortalecer la difusión de los servicios de MauleMed y apoyar la captación de pacientes, mientras que la Gestión de Encuestas de Satisfacción y la Gestión de Reclamos tienen como finalidad evaluar la experiencia usuaria y gestionar formalmente las situaciones planteadas por los pacientes. Esta claridad permitió identificar con precisión el alcance y los objetivos de cada proceso durante el levantamiento.
Contexto	P2	Durante el levantamiento fue posible identificar los principales clientes, proveedores, ejecutores, entradas, salidas y procesos relacionados con cada uno de los flujos analizados. Asimismo, se reconocieron las interacciones existentes entre Marketing, Administración, Calidad, Agendamiento, Dirección, áreas clínicas y pacientes, permitiendo comprender el contexto organizacional en que se desarrollan los procesos.
Documentación	P1	Si bien la organización dispone de formularios, planillas, registros e instrucciones para apoyar determinadas actividades, no existía una documentación integral que describiera formalmente el funcionamiento de los procesos, sus responsables, reglas de negocio y puntos de decisión. Gran parte del conocimiento permanece en las personas que ejecutan las actividades, por lo que la documentación generada durante este estudio constituye uno de los primeros esfuerzos de formalización.
Conocimiento	P2	Las personas entrevistadas demostraron un conocimiento detallado del funcionamiento de los procesos, identificando con claridad las actividades realizadas, los responsables involucrados, las excepciones y las principales reglas de negocio. Este nivel de conocimiento permitió elaborar modelos BPMN consistentes con la operación actual y validar la información obtenida durante el levantamiento.

Continúa en la página siguiente



Tabla 11 – Continuación

Capability	Nivel	Justificación
Habilidades	P2	Los responsables de los distintos procesos cuentan con las competencias necesarias para ejecutar las actividades que les corresponden. La planificación de campañas, la coordinación con proveedores externos, la gestión de consultas, la aplicación de encuestas y el tratamiento de reclamos se desarrollan adecuadamente gracias a la experiencia y conocimiento de las personas involucradas.
Comportamiento	P1	Aunque existe disposición para colaborar entre las distintas áreas involucradas, la coordinación del trabajo se desarrolla principalmente mediante mecanismos informales y depende en gran medida del conocimiento y experiencia de los responsables. No se evidenciaron instancias formales de seguimiento transversal, mecanismos estandarizados de coordinación ni una cultura de gestión basada en procesos que favorezca la mejora continua de manera sistemática.
Identidad	P2	Fue posible identificar responsables claramente definidos para cada uno de los procesos levantados. Administración y Marketing lideran la gestión de campañas digitales, mientras que el área de Calidad coordina la Gestión de Encuestas de Satisfacción y la Gestión de Reclamos. Asimismo, existen responsables específicos para actividades como la validación clínica, el agendamiento y la aprobación de campañas, lo que evidencia una asignación clara de responsabilidades operativas.
Actividades	P1	Si bien existen responsables operativos claramente identificados, no se evidenció la existencia de un Process Owner con autoridad transversal para monitorear el desempeño de los procesos, coordinar iniciativas de mejora y gestionar su evolución de manera sistemática. Las mejoras se implementan principalmente en respuesta a necesidades puntuales detectadas durante la operación.

Continúa en la página siguiente



Tabla 11 – Continuación

Capability	Nivel	Justificación
Sistema de información	P1	Los procesos utilizan diversas herramientas tecnológicas, entre ellas Meta Business Suite, Instagram, Facebook, Google Ads, WhatsApp Business, Cui.Date, formularios institucionales, correo electrónico y planillas Excel. Sin embargo, estas herramientas funcionan de manera independiente y no comparten información automáticamente, dificultando la trazabilidad entre campañas, consultas, agendamientos, satisfacción de pacientes y reclamos, además de requerir consolidaciones manuales para realizar análisis integrados.
Recursos Humanos	P1	No se identificaron mecanismos formales orientados a la capacitación continua, transferencia de conocimiento o desarrollo de competencias específicas para los procesos analizados. La continuidad operacional depende principalmente de la experiencia de determinadas personas y del conocimiento adquirido durante la ejecución diaria de las actividades.
Definición	P1	La organización dispone de indicadores asociados a distintos procesos, como alcance e interacciones de campañas, resultados de encuestas de satisfacción y cantidad de reclamos gestionados. Sin embargo, estos indicadores se encuentran definidos de manera independiente para cada área y no conforman un sistema integral que permita evaluar el desempeño global de los procesos.
Uso	P1	Las métricas disponibles son utilizadas principalmente para seguimiento operativo y análisis puntual de determinadas actividades. No obstante, no se evidenció un uso sistemático de los indicadores para monitorear tendencias, establecer metas, evaluar el desempeño de los procesos o apoyar ciclos formales de mejora continua basados en información integrada.

3.9. Diagnóstico de Madurez

La aplicación del Modelo de Madurez de Hammer evidencia que la Gestión General y Marketing Digital de MauleMed, junto con los procesos asociados de Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos, presenta un nivel de madurez intermedio. Si bien existen prácticas consolidadas que permiten ejecutar las actividades de manera adecuada, gran parte del funcionamiento de los procesos depende de la experiencia de sus responsables, de mecanismos de coordinación informales y de herramientas que operan de forma independiente.

Las principales fortalezas se concentran en los facilitadores de **Diseño y Ejecutores**. Los procesos poseen objetivos claramente definidos y los participantes comprenden su propósito, las actividades



que deben realizar y las relaciones existentes con otras áreas de la organización. Asimismo, fue posible identificar con claridad los principales clientes, proveedores, responsables y flujos de información, lo que permitió modelar los procesos mediante herramientas como BPMN, SIPOC y RECI.

Por otra parte, las personas que participan en los procesos cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar sus funciones. La planificación de campañas, la coordinación con proveedores externos, la atención de consultas, la aplicación de encuestas y la gestión de reclamos se ejecutan de manera consistente gracias a la experiencia acumulada por los responsables de cada actividad.

No obstante, el análisis evidencia diversas oportunidades de mejora relacionadas con la formalización de los procesos. Aunque existen responsables claramente identificados para las distintas actividades, no se observó la existencia de un *Process Owner* con autoridad transversal para monitorear el desempeño de los procesos, coordinar acciones de mejora y promover una gestión orientada por procesos. Asimismo, gran parte de la coordinación entre las áreas continúa realizándose mediante mecanismos informales y depende del conocimiento de las personas involucradas.

En relación con la infraestructura tecnológica, se identificó que la organización utiliza múltiples herramientas para apoyar la operación, entre ellas Meta Business Suite, Instagram, Facebook, Google Ads, WhatsApp Business, Cui.Date, formularios institucionales, correo electrónico y planillas Excel. Sin embargo, estas herramientas no se encuentran integradas entre sí, lo que obliga a realizar consolidaciones manuales y dificulta el seguimiento completo de la información.

Esta situación resulta especialmente evidente en el proceso de Marketing Digital, donde actualmente no es posible relacionar automáticamente una campaña con las consultas recibidas, los agendamientos registrados, las atenciones realizadas y los ingresos generados. Del mismo modo, en los procesos de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos, la información se administra principalmente mediante formularios, documentos y planillas que requieren una importante intervención manual para su consolidación y análisis.

Respecto de las métricas, se observó que la organización dispone de indicadores para distintos ámbitos de gestión, tales como alcance e interacciones de campañas digitales, resultados de satisfacción y cantidad de reclamos gestionados. Sin embargo, estos indicadores se encuentran distribuidos entre distintas herramientas y son utilizados principalmente para seguimiento operativo, sin conformar un sistema integrado de medición que permita monitorear el desempeño global de los procesos o apoyar la toma de decisiones mediante información consolidada.

En consecuencia, la madurez observada refleja una organización que ha logrado desarrollar procesos funcionales y conocidos por sus ejecutores, pero cuya operación continúa dependiendo en gran medida del conocimiento individual y de herramientas aisladas. Para avanzar hacia niveles superiores de madurez será necesario fortalecer la documentación de los procesos, formalizar los mecanismos de coordinación, integrar las distintas fuentes de información y establecer un sistema de indicadores que permita gestionar el desempeño de manera sistemática.

A partir del análisis realizado, se identifican las siguientes oportunidades de mejora:

- ◇ Formalizar la documentación de los procesos, incorporando procedimientos, reglas de negocio y criterios de decisión estandarizados.
- ◇ Fortalecer la coordinación entre las áreas mediante mecanismos formales de seguimiento y revisión periódica del desempeño.
- ◇ Reducir la dependencia del conocimiento individual mediante acciones de capacitación, documen-



tación y transferencia de conocimiento.

- ◇ Integrar las herramientas utilizadas para relacionar campañas digitales, consultas, agendamientos, atenciones e indicadores comerciales.
- ◇ Centralizar la información asociada a encuestas de satisfacción y reclamos para disminuir la utilización de registros manuales.
- ◇ Definir un conjunto de indicadores comunes que permitan evaluar de manera integral el desempeño de los procesos y apoyar la toma de decisiones.
- ◇ Implementar instancias periódicas de análisis y mejora continua basadas en información consolidada y en el seguimiento sistemático de los resultados.

En términos generales, los resultados obtenidos muestran que los procesos poseen una base operativa sólida y son ejecutados de manera consistente por sus responsables. No obstante, alcanzar niveles superiores de madurez requerirá avanzar hacia una gestión más estructurada, apoyada por procesos formalmente documentados, herramientas integradas e indicadores que permitan orientar la mejora continua de manera sistemática.

3.10. Perfil de Madurez del Proceso

Con el propósito de sintetizar los resultados obtenidos mediante la aplicación del Modelo de Madurez de Hammer, se calculó el nivel promedio alcanzado por cada uno de los cinco facilitadores evaluados. Este análisis permite identificar de manera agregada las principales fortalezas y brechas presentes en la Gestión General y Marketing Digital y en los procesos asociados de Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos.

Para realizar este análisis, los niveles P0–P4 fueron representados mediante una escala numérica equivalente, donde P0 corresponde a 0, P1 a 1, P2 a 2, P3 a 3 y P4 a 4. El promedio obtenido para cada facilitador permite representar gráficamente su nivel relativo de desarrollo y facilita la identificación de las capacidades que requieren mayor fortalecimiento.

Tabla 12: Perfil de madurez por facilitador

Facilitador	Nivel Promedio	Madurez	Diagnóstico
Diseño	1.67	P2	Medio
Ejecutores	1.67	P2	Medio
Responsable	1.50	P1	Medio
Infraestructura	1.00	P1	Bajo
Métricas	1.00	P1	Bajo

Como se observa en la Tabla 12, los niveles más altos de madurez se concentran en los facilitadores de Diseño y Ejecutores. Esto refleja que los procesos poseen propósitos claramente identificados, mantienen relaciones reconocibles con otras áreas de la organización y son ejecutados por personas que cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar sus actividades.

Sin embargo, estos facilitadores todavía presentan oportunidades de mejora. En Diseño, la principal



brecha corresponde al nivel de documentación existente, mientras que en Ejecutores se observa que la coordinación entre los participantes depende en gran medida de mecanismos informales y de la experiencia individual.

El facilitador Responsable presenta un nivel intermedio. Si bien los responsables operativos de los distintos procesos se encuentran claramente identificados, no se evidenció una gestión sistemática del desempeño ni la existencia de un *Process Owner* con responsabilidad transversal sobre su monitoreo y mejora continua.

Finalmente, Infraestructura y Métricas presentan los niveles relativos más bajos. La utilización de múltiples herramientas que operan de manera independiente limita la integración de la información, mientras que los indicadores disponibles se utilizan principalmente para seguimiento operativo y no conforman un sistema integral de medición del desempeño.

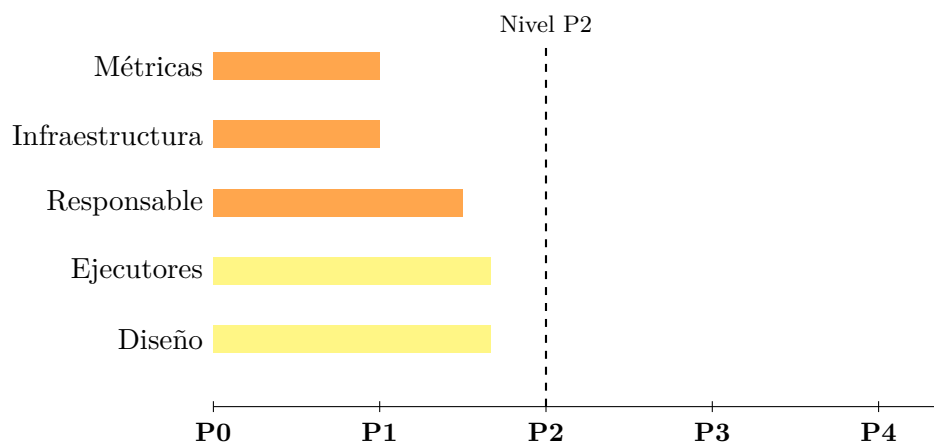


Figura 5: Perfil de madurez de los procesos según los facilitadores del Modelo de Hammer

La Figura 5 permite visualizar que ninguno de los facilitadores supera el nivel P2 y que las mayores brechas se concentran en los elementos relacionados con la infraestructura tecnológica, la utilización de indicadores y la gestión sistemática del desempeño. En consecuencia, el avance hacia niveles superiores de madurez requerirá complementar las capacidades actualmente existentes en las personas con mecanismos organizacionales más formalizados, herramientas integradas y una utilización más sistemática de la información.

3.11. Análisis Ejecutivo

El perfil de madurez obtenido evidencia un desarrollo relativamente equilibrado entre los distintos facilitadores evaluados, aunque con diferencias importantes entre las capacidades asociadas a las personas y aquellas relacionadas con la gestión del proceso y el soporte organizacional.

Las principales fortalezas se concentran en los facilitadores de Diseño y Ejecutores. El proceso presenta un propósito claramente definido, los responsables comprenden adecuadamente sus actividades y existe una coordinación efectiva entre las áreas involucradas para ejecutar las campañas de marketing, gestionar las encuestas de satisfacción y administrar los reclamos de los pacientes. Asimismo, los participantes poseen el conocimiento y la experiencia necesarios para desarrollar las actividades del proceso, permitiendo mantener la continuidad de la operación.



Sin embargo, la evaluación también evidencia oportunidades de mejora relevantes. La documentación formal del proceso es limitada y gran parte de los criterios utilizados para la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades permanece implícita en la experiencia de los responsables. Del mismo modo, aunque existe una responsable claramente identificada para la gestión del proceso, no se observó una administración sistemática de su desempeño mediante mecanismos formales de seguimiento o iniciativas estructuradas de mejora continua.

Las mayores brechas se concentran en los facilitadores de Infraestructura y Métricas. Si bien la organización dispone de diversas herramientas de apoyo, como RISPACS, Google Forms, Meta Business Suite y Microsoft Excel, estas funcionan de manera independiente, generando información distribuida y con escasa integración entre sí. Esta situación obliga a realizar consolidaciones manuales para elaborar informes y dificulta disponer de una visión unificada del desempeño de las actividades de marketing y experiencia de pacientes.

En cuanto a las métricas, se identificó la existencia de indicadores asociados principalmente a campañas digitales, producción de pacientes y resultados de encuestas de satisfacción. No obstante, estos indicadores son utilizados principalmente con fines de seguimiento operativo y no forman parte de un sistema integrado de medición que permita evaluar el desempeño global del proceso o apoyar de manera sistemática la toma de decisiones estratégicas.

En consecuencia, la madurez actual del proceso se sustenta principalmente en la experiencia de sus ejecutores y en la utilización de herramientas tecnológicas específicas para cada actividad, más que en mecanismos organizacionales formalizados o plataformas integradas de gestión. Esto representa una oportunidad para fortalecer la coordinación entre los distintos subprocesos, consolidar la información disponible y avanzar hacia una gestión más integrada, basada en datos y orientada a la mejora continua.

3.12. Diagnóstico Estratégico y Oportunidades de Mejora

El levantamiento realizado permitió identificar un conjunto de fortalezas y oportunidades de mejora relacionadas con la forma en que MauleMed gestiona sus actividades de marketing, la experiencia de pacientes y el seguimiento de indicadores asociados a la producción clínica. Estas observaciones fueron obtenidas a partir de las entrevistas realizadas con los responsables del proceso, el análisis de la documentación disponible, el modelamiento BPMN y la aplicación del Modelo de Madurez de Hammer.

En términos generales, el proceso logra cumplir adecuadamente sus objetivos operacionales y genera información útil para apoyar distintas decisiones de la organización. Sin embargo, el análisis evidencia diversas brechas asociadas a la integración de la información, la estandarización de procedimientos, la trazabilidad de las actividades y el uso sistemático de indicadores para la gestión.

Los hallazgos identificados constituyen la base para definir oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la capacidad de gestión del proceso, incrementar su madurez organizacional y facilitar una toma de decisiones cada vez más sustentada en información confiable y oportuna.



3.13. Hallazgos Principales

La Tabla 13 resume los principales hallazgos identificados durante el diagnóstico del proceso de Gestión General y Marketing Digital de MauleMed. Para cada hallazgo se indica el subproceso en el cual fue observado, la evidencia recopilada durante el levantamiento y el impacto estimado sobre el desempeño del proceso.



Tabla 13: Principales hallazgos del diagnóstico

ID	Subproceso	Hallazgo	Evidencia	Impacto
H1	Gestión General y Marketing Digital	Información distribuida en múltiples herramientas	La planificación, ejecución y seguimiento de campañas digitales se realiza utilizando diversas plataformas independientes, dificultando la consolidación de la información y la obtención de una visión integrada del desempeño de las acciones de marketing.	Alto
H2	Gestión General y Marketing Digital	Dependencia de actividades manuales para la elaboración de reportes	La información utilizada para evaluar campañas debe recopilarse y organizarse manualmente desde distintas fuentes antes de generar reportes para la toma de decisiones.	Medio
H3	Gestión de Encuestas de Satisfacción	Procesamiento manual de los resultados de las encuestas	Los resultados obtenidos desde Google Forms y otras fuentes deben revisarse y consolidarse manualmente para elaborar informes, dificultando el seguimiento oportuno de la satisfacción de los pacientes.	Alto
H4	Gestión de Reclamos	Escasa trazabilidad del ciclo de atención de reclamos	El seguimiento de los reclamos depende de registros independientes y coordinación entre distintas áreas, lo que dificulta conocer oportunamente el estado y los tiempos de resolución de cada caso.	Alto
H5	Transversal	Escasa integración entre los subprocesos	La información generada por Marketing, Encuestas de Satisfacción y Reclamos permanece distribuida entre distintas herramientas, dificultando el análisis conjunto de la experiencia del paciente y la toma de decisiones basada en información integrada.	Alto
H6	Transversal	Documentación limitada del proceso	Si bien los responsables conocen el funcionamiento del proceso, gran parte de los criterios operativos y reglas de negocio no se encuentran formalmente documentados, generando dependencia del conocimiento de los ejecutores.	Medio
H7	Transversal	Uso parcial de indicadores de desempeño	Existen indicadores asociados a campañas digitales, satisfacción y reclamos; sin embargo, estos no conforman un sistema integrado que permita evaluar el desempeño global del proceso ni apoyar sistemáticamente la mejora continua.	Medio



3.14. Oportunidades de Mejora

Los hallazgos identificados permiten establecer un conjunto de oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la gestión del proceso, incrementar su nivel de madurez y reducir la dependencia de actividades manuales. Estas oportunidades no corresponden aún a soluciones específicas, sino a ámbitos donde la organización puede intervenir para mejorar su desempeño y fortalecer la gestión de marketing, la medición de la satisfacción de los pacientes y la administración de reclamos.

La Tabla 14 presenta la relación entre los principales hallazgos identificados y las oportunidades de mejora propuestas.

Tabla 14: Oportunidades de mejora identificadas

Hallazgo	Oportunidad de mejora
Información distribuida en múltiples herramientas	Centralizar la información utilizada por los distintos subprocesos, facilitando el acceso, la consulta y el análisis integrado de la gestión.
Dependencia de actividades manuales para la elaboración de reportes	Estandarizar la generación de reportes y disminuir las tareas manuales asociadas a la recopilación y consolidación de información.
Procesamiento manual de los resultados de las encuestas	Fortalecer el seguimiento de la satisfacción de los pacientes mediante mecanismos que permitan consolidar y analizar oportunamente los resultados obtenidos.
Escasa trazabilidad del ciclo de atención de reclamos	Mejorar el seguimiento de los reclamos mediante mecanismos que permitan conocer su estado, responsables y tiempos de resolución.
Escasa integración entre los subprocesos	Favorecer una gestión coordinada entre Marketing, Encuestas de Satisfacción y Reclamos, promoviendo el intercambio de información y una visión integral de la experiencia del paciente.
Documentación limitada del proceso	Formalizar procedimientos, responsabilidades y criterios de ejecución para disminuir la dependencia del conocimiento tácito y facilitar la continuidad operacional.
Uso parcial de indicadores de desempeño	Fortalecer la gestión basada en indicadores mediante un conjunto integrado de métricas que permita evaluar el desempeño global del proceso y apoyar la mejora continua.

3.15. Plan de Transformación del Proceso

El diagnóstico realizado permitió identificar que el proceso de Gestión General y Marketing Digital presenta fortalezas relacionadas con el compromiso de sus ejecutores, el conocimiento de las actividades desarrolladas y la utilización de distintas herramientas digitales para apoyar la opera-



ción. Sin embargo, también se identificaron brechas asociadas a la integración de la información, la dependencia de actividades manuales, la limitada trazabilidad de algunos subprocesos y la escasa formalización de procedimientos.

Las oportunidades de mejora descritas anteriormente evidencian que el proceso cumple adecuadamente su propósito operativo, pero su desempeño depende en gran medida de la coordinación entre personas y del uso de herramientas independientes, lo que dificulta obtener una visión integrada de la gestión y limita la capacidad para realizar un seguimiento sistemático de las actividades.

Con el propósito de abordar estas brechas, se propone un Plan de Transformación orientado a fortalecer la gestión del proceso mediante iniciativas organizacionales y tecnológicas que permitan incrementar la trazabilidad de la información, mejorar la coordinación entre los distintos subprocesos y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Más que introducir mejoras puntuales sobre actividades específicas, el plan busca evolucionar integralmente la forma en que MauleMed gestiona sus actividades de marketing, el seguimiento de la satisfacción de los pacientes y la administración de reclamos, fortaleciendo las capacidades organizacionales que sustentan estos procesos

**3.15.1. Propuesta 1. Formalización y estandarización del proceso**

Aspecto	Descripción
Problema	Los tres subprocesos que conforman la Gestión General y Marketing Digital dependen en gran medida del conocimiento y experiencia de sus ejecutores. Además, los procedimientos y criterios utilizados para desarrollar las distintas actividades no se encuentran completamente documentados ni estandarizados.
Objetivo	Formalizar la ejecución del proceso mediante la definición de procedimientos, responsabilidades y criterios comunes que permitan asegurar una operación consistente y facilitar la continuidad operacional.
Propuesta	Desarrollar un marco documental que describa las actividades, responsables, reglas de negocio, flujos de trabajo e indicadores mínimos asociados a los subprocesos de Gestión General y Marketing Digital, Gestión de Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos.
Beneficios esperados	◇ Disminución de la dependencia del conocimiento tácito. ◇ Mayor continuidad operacional. ◇ Homogeneidad en la ejecución de los procesos. ◇ Facilita la capacitación de nuevos ejecutores. ◇ Base para futuras iniciativas de transformación.
Ejes estratégicos	Capital Humano y Excelencia Operacional.
Prioridad	Alta.

**3.15.2. Propuesta 2. Plataforma de Gestión de Marketing y Experiencia del Paciente**

Aspecto	Descripción
Problema	La información utilizada por los subprocesos de Marketing, Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos se encuentra distribuida en múltiples herramientas independientes, dificultando la coordinación entre áreas, la trazabilidad de las actividades y el acceso oportuno a información para la toma de decisiones.
Objetivo	Centralizar la gestión del proceso mediante una plataforma única que integre los distintos subprocesos y permita administrar la información de forma estructurada.
Propuesta	Implementar una Plataforma de Gestión de Marketing y Experiencia del Paciente que integre la planificación de campañas, el seguimiento de encuestas de satisfacción, la administración de reclamos, el registro de actividades, la generación de indicadores y el acceso a información consolidada para los distintos responsables del proceso. La plataforma constituye el principal habilitador tecnológico del Plan de Transformación, proporcionando una base común para la gestión integrada de los tres subprocesos y permitiendo incorporar progresivamente nuevas funcionalidades de automatización y análisis.
Beneficios esperados	◇ Centralización de la información. ◇ Mayor trazabilidad de las actividades. ◇ Disminución de tareas manuales. ◇ Información disponible de forma oportuna. ◇ Mejor coordinación entre los subprocesos. ◇ Base para futuras iniciativas de transformación digital.
Ejes estratégicos	Excelencia Operacional, Transformación Digital y Gestión Basada en Datos.
Prioridad	Muy Alta.

**3.15.3. Propuesta 3. Gestión Inteligente de la Relación con el Paciente**

Aspecto	Descripción
Problema	Actualmente, las actividades de marketing, las encuestas de satisfacción y la gestión de reclamos se desarrollan de manera mayoritariamente independiente, dificultando realizar un seguimiento continuo de la relación con los pacientes e identificar oportunamente oportunidades de mejora.
Objetivo	Evolucionar desde una gestión reactiva hacia una gestión proactiva de la relación con los pacientes, utilizando la información generada durante todo el proceso para apoyar la toma de decisiones y la mejora continua.
Propuesta	Incorporar mecanismos que permitan segmentar pacientes, realizar seguimiento de campañas, monitorear resultados de satisfacción, controlar el estado de los reclamos y generar alertas sobre situaciones que requieran atención o acciones de mejora, utilizando de manera integrada la información disponible durante todo el proceso.
Beneficios esperados	◇ Mejor conocimiento de los pacientes. ◇ Mayor capacidad para anticipar oportunidades de mejora. ◇ Seguimiento continuo de la experiencia del paciente. ◇ Disminución de actividades reactivas. ◇ Mejor coordinación entre los distintos subprocesos.
Ejes estratégicos	Excelencia Operacional, Transformación Digital y Gestión Basada en Datos.
Prioridad	Alta.

**3.15.4. Propuesta 4. Fortalecimiento de la gestión de la experiencia del paciente**

Aspecto	Descripción
Problema	La información proveniente de las encuestas de satisfacción y de los reclamos es gestionada de manera independiente, dificultando identificar tendencias, oportunidades de mejora y acciones preventivas que permitan fortalecer la experiencia de los pacientes.
Objetivo	Consolidar una visión integral de la experiencia del paciente que permita utilizar la información recopilada para apoyar la mejora continua de los servicios prestados por MauleMed.
Propuesta	Establecer mecanismos de seguimiento que permitan relacionar los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción, los reclamos recibidos y las acciones implementadas por la organización, favoreciendo una retroalimentación sistemática orientada a la mejora de la atención.
Beneficios esperados	◇ Mejor comprensión de la experiencia de los pacientes. ◇ Identificación de oportunidades de mejora. ◇ Disminución de problemas recurrentes. ◇ Mayor orientación hacia la calidad del servicio. ◇ Retroalimentación continua para la organización.
Ejes estratégicos	Excelencia Operacional y Gestión Basada en Datos.
Prioridad	Alta.

3.15.5. Alineación estratégica de las propuestas

Las propuestas de transformación presentadas anteriormente fueron definidas considerando las principales brechas identificadas durante el diagnóstico y los cuatro ejes estratégicos establecidos para la transformación del proceso. Cada propuesta contribuye al fortalecimiento de distintas capacidades organizacionales y, en conjunto, conforman una estrategia integral orientada a mejorar la gestión de marketing, la experiencia de los pacientes y la administración de reclamos.

La Tabla 15 resume la relación entre las propuestas de transformación y los ejes estratégicos definidos para el proceso.



Tabla 15: Alineación entre las propuestas de transformación y los ejes estratégicos.

Propuesta	Capital Humano	Excelencia Operacional	Transformación Digital	Gestión Basada en Datos
Formalización y estandarización del proceso	✓	✓		
Plataforma de Gestión de Marketing y Experiencia del Paciente		✓	✓	✓
Gestión Inteligente de la Relación con el Paciente		✓	✓	✓
Gestión basada en indicadores			✓	✓

Como se observa en la Tabla 15, las propuestas no corresponden a iniciativas independientes, sino que forman parte de una estrategia de transformación integral.

La formalización del proceso constituye la base para disminuir la dependencia del conocimiento tácito y asegurar una ejecución homogénea de las actividades desarrolladas por los distintos responsables. Sobre esta base, la implementación de una Plataforma de Gestión de Marketing y Experiencia del Paciente actúa como el principal habilitador tecnológico, permitiendo centralizar la información generada por los distintos subprocesos y fortalecer su trazabilidad.

A partir de esta infraestructura, la organización podrá evolucionar hacia una gestión más proactiva de la relación con los pacientes, aprovechando de manera integrada la información proveniente de campañas de marketing, encuestas de satisfacción y reclamos para identificar oportunidades de mejora y fortalecer la experiencia de los usuarios.

Finalmente, la incorporación de un sistema de indicadores permitirá monitorear permanentemente el desempeño del proceso, evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos y establecer un ciclo sistemático de mejora continua sustentado en información confiable y oportuna.

3.16. Sistema de Medición del Desempeño

La implementación de las propuestas de transformación requiere incorporar mecanismos que permitan monitorear de forma permanente el desempeño del proceso y evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos. En este contexto, la medición constituye un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad de las mejoras implementadas y promover una gestión orientada por información



objetiva.

Actualmente, MauleMed dispone de algunos indicadores asociados principalmente al desempeño de campañas digitales y a los resultados de las encuestas de satisfacción. Sin embargo, estos indicadores se encuentran distribuidos entre distintas herramientas y no conforman un sistema integrado que permita evaluar de manera conjunta el comportamiento de los tres subprocesos que conforman la Gestión General y Marketing Digital.

Con el propósito de fortalecer la gestión del proceso, se propone implementar un Sistema de Medición del Desempeño compuesto por un conjunto de indicadores organizados en cuatro dimensiones: Marketing Digital, Experiencia del Paciente, Gestión de Reclamos y Gestión Estratégica. Esta estructura permitirá monitorear integralmente el proceso, detectar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización.

3.16.1. Dimensiones del Sistema de Medición

Dimensión	Propósito
Marketing Digital	Evaluar el desempeño de las campañas de difusión, el alcance de las acciones de marketing y la efectividad de las iniciativas desarrolladas para promover los servicios de MauleMed.
Experiencia del Paciente	Monitorear la satisfacción de los pacientes mediante el análisis sistemático de las encuestas aplicadas y otros mecanismos de retroalimentación.
Gestión de Reclamos	Evaluar la oportunidad, trazabilidad y calidad del proceso de atención de reclamos, promoviendo una resolución eficiente y la identificación de causas recurrentes.
Gestión Estratégica	Monitorear el desempeño global del proceso mediante indicadores consolidados que apoyen la toma de decisiones, la planificación y la mejora continua.

Tabla 16: Dimensiones propuestas para el Sistema de Medición del Desempeño.

3.16.2. Indicadores propuestos

Tabla 17: Indicadores propuestos para el proceso de Gestión General y Marketing Digital.

Dimensión	Indicador	Frecuencia	Responsable	Objetivo
-----------	-----------	------------	-------------	----------



Marketing		Alcance de campañas digitales	Mensual	Marketing	Evaluar el impacto de las campañas
Marketing		Tasa de interacción en redes sociales	Mensual	Marketing	Medir el compromiso de los usuarios
Experiencia del Paciente		Índice de satisfacción de pacientes	Mensual	Marketing	Monitorear la satisfacción
Experiencia del Paciente		Tasa de respuesta de encuestas	Mensual	Marketing	Incrementar representatividad
Gestión de Reclamos		Tiempo promedio de resolución	Mensual	Administración	Reducir tiempos de atención
Gestión de Reclamos		Porcentaje de reclamos resueltos dentro del plazo	Mensual	Administración	Mejorar el cumplimiento
Gestión de Reclamos		Reclamos reiterados	Mensual	Administración	Identificar problemas recurrentes
Gestión Estratégica		Cumplimiento de campañas planificadas	Mensual	Marketing	Evaluar la ejecución del plan
Gestión Estratégica		Acciones de mejora implementadas	Trimestral	Dirección	Impulsar mejora continua
Gestión Estratégica		Indicadores dentro de meta	Mensual	Dirección	Monitorear el desempeño global

3.16.3. Uso de los indicadores

Los indicadores propuestos no deben entenderse únicamente como mecanismos de control, sino como herramientas para apoyar la gestión integral del proceso y promover la mejora continua. Su utilización permitirá monitorear el comportamiento de los distintos subprocesos, identificar oportunamente desviaciones respecto de los objetivos definidos y evaluar el impacto de las iniciativas implementadas.



Asimismo, la consolidación de estos indicadores en tableros de control facilitará el acceso a información oportuna para los distintos niveles de la organización, fortaleciendo una gestión basada en datos y permitiendo analizar de manera conjunta el desempeño de las actividades de marketing, la satisfacción de los pacientes y la gestión de reclamos.

3.17. Roadmap de Implementación de la Transformación

La implementación de las propuestas de transformación requiere un proceso gradual que permita fortalecer las capacidades organizacionales antes de incorporar herramientas tecnológicas y mecanismos avanzados de gestión. Un enfoque progresivo facilita la adopción de nuevas prácticas, disminuye los riesgos asociados al cambio y permite que las mejoras implementadas generen beneficios sostenibles para la organización.

En este contexto, se propone un roadmap compuesto por cinco fases secuenciales. La primera corresponde al trabajo desarrollado durante la presente consultoría, mientras que las etapas posteriores representan las acciones recomendadas para que MauleMed evolucione hacia una gestión más integrada, estandarizada y orientada por datos.

Cada una de estas fases constituye un paso dentro de un proceso continuo de transformación, donde los resultados obtenidos en una etapa proporcionan la base necesaria para desarrollar la siguiente.

3.17.1. Fase 0. Diagnóstico y Diseño del Proceso

Esta fase corresponde al trabajo desarrollado durante la presente consultoría y constituye el punto de partida para la transformación del proceso de Gestión General y Marketing Digital. Su propósito fue comprender el funcionamiento actual del proceso, identificar oportunidades de mejora y definir una propuesta integral de transformación alineada con las necesidades de MauleMed.

Durante esta etapa se desarrollaron los siguientes entregables:

- ◇ Levantamiento del proceso mediante entrevistas con los principales actores involucrados.
- ◇ Modelamiento del proceso AS-IS utilizando BPMN.
- ◇ Identificación de fortalezas, brechas y oportunidades de mejora.
- ◇ Evaluación del nivel de madurez mediante el Modelo de Hammer.
- ◇ Elaboración del Plan de Transformación.
- ◇ Definición de propuestas de mejora y sistema de indicadores.

Esta fase se considera completada y constituye la base para las etapas posteriores de transformación.

3.17.2. Fase I. Estandarización del Proceso

Una vez concluida la etapa de diagnóstico, la organización deberá avanzar en la formalización del proceso mediante la definición de procedimientos, responsabilidades y criterios de ejecución comunes para los distintos subprocesos. Esta etapa tiene como propósito disminuir la dependencia del conocimiento tácito y establecer una base organizacional que permita sostener las iniciativas de transformación propuestas.

Las principales actividades recomendadas son:



- ◇ Formalizar los procedimientos asociados a Marketing, Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos.
- ◇ Definir claramente los roles y responsabilidades de los distintos participantes del proceso.
- ◇ Documentar las reglas de negocio y criterios utilizados durante la ejecución de las actividades.
- ◇ Diseñar y validar el proceso objetivo (TO-BE) considerando las oportunidades de mejora identificadas.
- ◇ Socializar los nuevos procedimientos con las áreas involucradas.

Como resultado de esta etapa, MauleMed dispondrá de un proceso estandarizado, documentado y conocido por los distintos responsables, generando las condiciones necesarias para avanzar hacia una gestión más integrada y eficiente.

3.17.3. Fase II. Integración de la Gestión

Una vez formalizados los procesos, la organización podrá avanzar en la integración de los distintos subprocesos que conforman la Gestión General y Marketing Digital. El objetivo de esta etapa es fortalecer la coordinación entre Marketing, Encuestas de Satisfacción y Gestión de Reclamos, promoviendo una administración basada en información integrada y criterios comunes de gestión.

Las principales actividades recomendadas son:

- ◇ Definir un flujo integrado de información entre los tres subprocesos.
- ◇ Homologar criterios para el registro y seguimiento de actividades.
- ◇ Estandarizar los formatos utilizados para almacenar información relevante.
- ◇ Definir un modelo común para la administración de indicadores.
- ◇ Establecer mecanismos de coordinación entre las áreas responsables.

Al finalizar esta etapa, MauleMed dispondrá de un proceso integrado, donde la información generada por los distintos subprocesos podrá ser utilizada de forma coordinada para apoyar la gestión y la toma de decisiones.

3.17.4. Fase III. Transformación Digital

Con los procesos formalizados e integrados, la organización estará en condiciones de incorporar herramientas tecnológicas que permitan soportar digitalmente la Gestión General y Marketing Digital. El propósito de esta etapa es centralizar la información, fortalecer la trazabilidad de las actividades y disminuir la dependencia de registros distribuidos entre múltiples herramientas.

Las principales actividades recomendadas son:

- ◇ Implementar una plataforma que centralice la gestión de Marketing, Encuestas de Satisfacción y Reclamos.
- ◇ Digitalizar el registro y seguimiento de las actividades desarrolladas en cada subproceso.
- ◇ Centralizar la información asociada a campañas, encuestas, reclamos e indicadores.
- ◇ Automatizar actividades repetitivas y notificaciones relacionadas con el proceso.
- ◇ Implementar tableros ejecutivos y reportes para apoyar la toma de decisiones.

Como resultado de esta etapa, MauleMed dispondrá de un proceso soportado por herramientas



tecnológicas que permitirán mejorar la coordinación entre las áreas involucradas, disponer de información consolidada y fortalecer la gestión basada en datos.

3.17.5. Fase IV. Consolidación y Mejora Continua

La última etapa del roadmap tiene como propósito consolidar el nuevo modelo de gestión mediante la incorporación de mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y mejora continua. Durante esta fase, la organización utilizará la información generada por el proceso para monitorear su desempeño, identificar oportunidades de optimización y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Las principales actividades recomendadas son:

- ◇ Implementar formalmente el Sistema de Medición del Desempeño propuesto.
- ◇ Monitorear periódicamente los indicadores definidos para el proceso.
- ◇ Realizar reuniones de seguimiento para evaluar el desempeño de los distintos subprocesos.
- ◇ Revisar y actualizar periódicamente los procedimientos y reglas de negocio.
- ◇ Incorporar nuevas oportunidades de automatización y optimización cuando corresponda.
- ◇ Promover una cultura organizacional orientada a la mejora continua y la toma de decisiones basada en información.

Como resultado de esta etapa, MauleMed dispondrá de un proceso consolidado, monitoreado mediante indicadores y respaldado por mecanismos permanentes de mejora continua, fortaleciendo su capacidad para adaptarse a nuevas necesidades y asegurar la sostenibilidad de las iniciativas implementadas.

3.18. Impacto Esperado de la Transformación

La implementación gradual de las propuestas presentadas permitirá fortalecer las capacidades organizacionales relacionadas con la gestión de marketing, el seguimiento de la satisfacción de los pacientes y la administración de reclamos. Más allá de la incorporación de nuevas herramientas de apoyo, la transformación propuesta busca mejorar la forma en que la organización planifica, ejecuta, monitorea y utiliza la información generada por estos procesos para apoyar la toma de decisiones.

Los principales impactos esperados se agrupan en cuatro dimensiones: operacional, organizacional, tecnológica y estratégica.



Tabla 18: Impacto esperado de la implementación del Plan de Transformación.

Dimensión	Impacto esperado	Valor para MauleMed
Operacional	◊ Mayor integración entre los subprocesos. ◊ Disminución de actividades manuales. ◊ Mayor trazabilidad de las actividades. ◊ Estandarización de procedimientos. ◊ Mejor coordinación entre áreas.	◊ Procesos más eficientes. ◊ Reducción de errores operacionales. ◊ Mejor continuidad del proceso. ◊ Mayor capacidad de seguimiento.
Organizacional	◊ Disminución de la dependencia del conocimiento individual. ◊ Formalización de procedimientos. ◊ Claridad de roles y responsabilidades. ◊ Mejor colaboración entre áreas.	◊ Facilita la capacitación. ◊ Mayor continuidad operacional. ◊ Fortalece la gestión del conocimiento.
Tecnológica	◊ Centralización de la información. ◊ Digitalización de registros. ◊ Automatización de actividades. ◊ Disponibilidad de información integrada.	◊ Mayor trazabilidad. ◊ Información disponible oportunamente. ◊ Base para futuras iniciativas tecnológicas.
Estratégica	◊ Implementación de indicadores. ◊ Monitoreo permanente del desempeño. ◊ Gestión basada en información. ◊ Mejora continua.	◊ Mejor toma de decisiones. ◊ Mayor capacidad de planificación. ◊ Fortalecimiento de la gestión institucional.

La implementación del Plan de Transformación permitirá generar beneficios que trascienden la optimización de actividades específicas. Desde una perspectiva operacional, se espera fortalecer la coordinación entre los distintos subprocesos y reducir la dependencia de actividades manuales mediante una gestión más integrada de la información. En el ámbito organizacional, la formalización de procedimientos contribuirá a disminuir la dependencia del conocimiento tácito y facilitará la continuidad operacional frente a cambios en los equipos de trabajo.

Paralelamente, la incorporación de herramientas tecnológicas permitirá centralizar la información, mejorar la trazabilidad de las actividades y facilitar el acceso a información consolidada para los distintos niveles de la organización. Finalmente, la implementación de un sistema de indicadores fortalecerá la capacidad de MauleMed para monitorear el desempeño del proceso, identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones mediante información objetiva y oportuna.



3.19. Análisis de Riesgos e Impacto Organizacional

Las brechas identificadas durante el diagnóstico no solo afectan la eficiencia del proceso de Gestión General y Marketing Digital, sino que también incrementan la exposición de la organización a riesgos que pueden impactar la calidad del servicio, la experiencia de los pacientes y la capacidad de tomar decisiones oportunas.

Si bien el alcance de la presente consultoría no considera la cuantificación económica de estos riesgos, es posible identificar las principales consecuencias organizacionales asociadas a mantener el proceso en su estado actual.

Tabla 19: Principales riesgos organizacionales asociados al proceso actual y propuestas de mitigación.

Riesgo identificado	Consecuencia para la organización	Impacto	Propuesta de mitigación
Información distribuida	La utilización de múltiples herramientas dificulta consolidar información, genera duplicidad de registros y limita la obtención de una visión integrada del proceso.	Alto	Plataforma de Gestión de Marketing y Experiencia del Paciente.
Dependencia del conocimiento individual	La continuidad del proceso depende de la experiencia de determinados ejecutores, aumentando el riesgo frente a cambios de personal o ausencias prolongadas.	Alto	Formalización y estandarización del proceso.
Seguimiento limitado de la experiencia del paciente	La falta de integración entre encuestas y reclamos dificulta detectar oportunamente oportunidades de mejora y problemas recurrentes.	Alto	Gestión Inteligente de la Relación con el Paciente.
Uso parcial de indicadores	La inexistencia de un sistema integrado de indicadores limita la capacidad para monitorear el desempeño del proceso y apoyar la toma de decisiones.	Medio	Gestión basada en indicadores.
Escasa trazabilidad de las actividades	El seguimiento de campañas, encuestas y reclamos resulta más complejo al encontrarse distribuido entre distintas herramientas y registros independientes.	Medio	Plataforma de Gestión de Marketing y Experiencia del Paciente.

La permanencia de estas brechas limita la capacidad de MauleMed para gestionar de manera integrada sus actividades de marketing y los mecanismos utilizados para recoger y analizar la experiencia de



los pacientes. Asimismo, dificulta la disponibilidad de información oportuna para apoyar la toma de decisiones y restringe las posibilidades de implementar un proceso sistemático de mejora continua.

En consecuencia, las propuestas de transformación presentadas en este informe buscan reducir progresivamente la exposición de la organización a estos riesgos mediante el fortalecimiento de las capacidades organizacionales, la integración de la información y la incorporación de mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación.